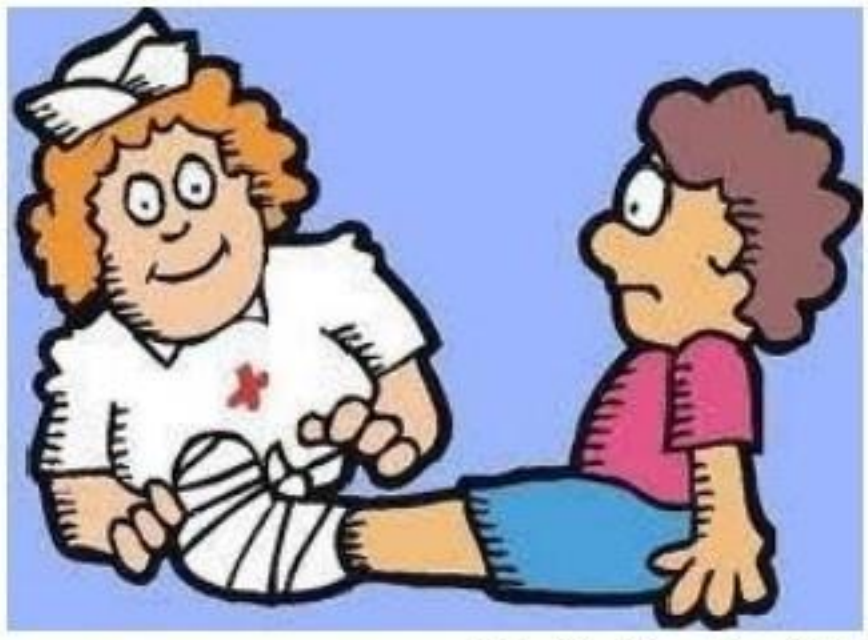
ممقدمة

قد تجد نفسك وأنت في مكان العمل أو المدرسة أو المنزل أو الشارع أينما كنت تقف وجهاً لوجه أمام شخص عزيز عليك أباً كان أو ابناً أو قريباً أو صديقاً أو حتى إنساناً لا تعرفه وقد تعرض لجرح ، نزيف ،، كسر ، صدمة ، أو لنوبات مرض ما.

فهل فكرت ماذا سيكون تصرفك ؟ وهل ستقف عاجزاً عن تقديم بعض الإسعافات التي قد تنقذ حياته حتى يتم نقله إلى أقرب مستشفى أو عيادة طبية ، لتلقي العلاج المناسب ، إن الإسعافات الأولية على الرغم أنها علاج مؤقت لأي أزمة أو حالة إلا أنها قد تنقذ حياة الإنسان ولهذا فيجب على كل شخص منا التعرف على مبادئ الإسعافات الأولية ووسائلها وكيفية التعامل مع المصاب ، وهذا ما سنحاول عرضه فيما يلي

تعريف الإسعافات الأولية

الإسعافات الأولية هي الرعاية والعناية الأولية والفورية والمؤقتة التي يتلقاها الإنسان نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة أدت إلى النزيف أو الجروح أو الكسور أو الإغماء .. الخ لإنقاذ حياته وحتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة له بوصول الطبيب لمكان الحادث أو بنقله إلى أقرب مستشفى أو عيادة طبية



أهداف الإسعاف الأولية

١.الحفاظ على حياة المصاب.

٢.منع تدهور حالة المصاب.

٣.مساعدة المصاب على الشفاء.

مبادئ الإسعافات الأولية

١.السيطرة التامة على موقع الحدث

٢.ألا يعتبر المصاب ميتاً لمجرد زوال ظواهر الحياة مثل توقف التنفس أو النبض

٣.إبعاد المصاب عن مصدر الخطر.
٤.الاهتمام بعمليات التنفس الاصطناعي وإنعاش القلب والنزيف والصدمة، وما إلى ذلك.
٥.العناية بالحالة قبل نقلها إلى المستشفى.
٦.الاهتمام براحة المصاب.
٧.الاهتمام بحفظ وتدوين كافة المعلومات المتوفرة عن الحادث والإجراءات التي اتُخذت.

المسعف - مسئولياته - خطوات عمله

المسعف

هو الشخص الذي يقوم تقديم الإسعافات الأولية والعناية بالمصاب أو من تعرض لحالة مرضية مفاجئة، يشترط أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل بحصوله على التدريب المناسب بالمراكز الصحية المتخصصة ولديه المعلومات التي تمكنه من تقديم الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض بشكل صحيح لإنقاذ حياته.

مسؤولية المسعف الأولي

*تقييم وتشخيص صحيح وسريع سريع للإصابة أو الحالة لمعرفة سبب الحادث وتحديد نوع المرض أو الإصابة معتمداً على وصف وقائع الحادث والأعراض والعلامات المشاهدة.
*فحص المصاب بالكامل والاهتمام بالإصابة كبيرة كانت أم صغيرة وذلك لأنه غالباً ما يكتفي المسعف بالإصابة الأولى خاصة إذا كانت هذه الإصابة كبيرة ويهمل باقي الإصابات الصغيرة والتي قد تكون لها خطورتها.
*تقديم المعالجة الفورية المناسبة حسب الإصابة أو المرض.
*نقل المصاب إلى المستشفى أو المركز الصحي حسب خطورة الحالة.

شروط لابد من توافرها بالمسعف

١-هدوء الأعصاب.
٢-سرعة البديهة وسرعة التصرف.
٣-الثقة بالنفس والشجاعة دون اضطراب أو توتر وانعكاس ذلك على المصاب نفسه بطمأنته وتبسيط الأمور له ونزع التوتر منه.
الإحاطة بما ينبغي عمله
٥-عدم تعريض النفس للخطر .(مثلا) فلا يحاول أنقاذ غريق إذا كان لايعرف السباحة

خطوات عمل المسعف

*يجب على المسعف أن يتصرف في حدود معلوماته الطبية التي تمكنه من تقديم الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض بشكل صحيح لإنقاذ حياته وأن يقوم بتقييم الموقف ومعرفة ما حدث للمصاب حتى يتمكن من تقديم الإسعافات الأولية التي تتفق مع نوعية الإصابة أو المرض نظراً لاختلاف نوعية الإسعافات بحسب نوع الإصابة.
*يجب على المسعف أن يطمئن المصاب ويهدئه من روعه ويزيل اضطرابه وتشجيعه ومعاملته بلطف والتخفيف من انزعاجه.
*يجب على المسعف أن لا يسمح بتراحم الناس حول المصاب لمساعدته على التنفس وتهدئة المصاب.

.*يجب على المسعف الاحتفاظ بشهود الحادث واستدعاء الطبيب والشرطة
*يجب على المسعف محاولة إيقاف النزيف أو عمل جبيرة أو تنفس صناعي وتدليك القلب حسب الحالة.
*يجب على المسعف أن يعرف ما حدث للمصاب بالاستفسار ودراسة الملابسات وأن يصل من ذلك إلى تشخيص تقريبي للإصابة المريض أو مرضه ومن أمثلة ذلك:;

.المعرفة التامة بقواعد الإسعافات الأولية وطريقة تنفيذها .
.تأمين موقع الحادث، وعزل الجسم وتقييم مكان الحادث .
.تنفيذ عملية التنفس الصناعي وكيفية فتح ممرات للهواء .
.الوضع الملائم للمريض أو المصاب .
.معرفة الأعراض وعلامات الخطر للمشاكل الطبية .
.معرفة علامات الاستجابة من عدمها للمصاب .
.السيطرة على النزيف الخارجي .
.معرفة ما إذا كان يوجد نزيف داخلي أم لا .
.التعامل مع إصابات العمود الفقري .
.توافر المعلومات العامة لديه عن جسم الإنسان وتشريحه، وأعضائه وأجهزته المختلفة .
.كيفية حمل المريض وذلك لتخفيف تعرضه لمزيد من الضرر أو الأذى .
.معرفة الأعراض المتعلقة بمختلف الأمراض وكيفية التعامل معها .
.تدليك القلب .
.التعامل مع الحروق والكسور .
.كيفية تضميد الجراح .
.كيفية التعامل مع إصابات الأطفال .

صندوق الإسعافات الأولية

يعتبر صندوق الإسعافات الأولية ضرورة لا غنى عنه في المنزل أو السيارة أو العمل أو الرحلات، فوجود وسائل الإسعافات الأولية تساعد على إسعاف المصاب بسرعة، وتجنب تدهور حالته وتفادي حدوث المضاعفات المترتبة عن الإصابة، فمعظم الإصابات يمكن التعامل معها بسهولة وبقليل من الخبرة وكثير من العناية وتجهيز صندوق الإسعافات الأولية على أكمل وجه. ويجب حفظ مواد الإسعافات الأولية داخل صندوق محكم الغلق والكتابة عليه بشكل واضح ووضعه في مكان ظاهر يمكن الوصول إليه. حقيبة الإسعافات الأولية للرحلات يجب أن تكون من النوع الخفيف ولها مقابض لسهولة حملها.



ملاحظة هامة:في المنزل يجب حفظ حقيبة أو صندوق الإسعافات الأولية بعيد عن متناول الأطفال الصغار لضمان سلامتهم.

تأكد من تاريخ صلاحية المواد من فترة لأخرى وقم باستبدال كل مادة انتهى تاريخ صلاحيتها .

احتفظ بقائمة أرقام هواتف الطوارئ بصندوق أو بحقيبة الإسعافات الأولية .

يجب الاحتفاظ داخل صندوق الإسعافات الأولية بدليل المواد والحالة التي يتم استخدامها . كدليل إرشادي عند استعمال الأدوية.

القواعد الأساسية في الإسعاف الأولي

١-إبعاد المصاب عن مصدر الخطر

٢-فك الأربطة والأحزمة والملابس الضيقة

تمزيق أو قص الملابس حول مكان الجرح أو الإصابة

٤-إذا كان المريض في حالة أغماء ابحث عن أي جسم غريب في الفم كالأسنان الصناعية أو بقايا القيء وأزلها وأمل رأسه جانبا وإلى الأسفل واجذب لسانه إلى الأمام حتى لا يختنق.

٥-إذا كان التنفس متوقفا أجر له تنفسا صناعيا من الفم للفم فورا .

٦-إذا كان النزف ظاهرا يوقف النزف بالضغط عاي موضع النزف باليد أو بقطعة قماش نظيفة أو يربط في مكان أعلى من الجرح برباط ضاغط

٧-في حالة الاشتباه بوجود نزف داخلي يجب الإسراع لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى دون تمهل .

وعلامات النزف الداخلي هي فلق المصاب – شكواه من العطش – سرعة نفسه – شحوب لونه – برودة جلده – وسرعة في النبض وضعفه – عدم وجود إصابة ظاهرة

٨-إذا كان في حالة ضربة شمس يمدد المصاب بعيدا عن الشمس ورأسه أعلى من قدميه مع غمس أطرافه في ماء بارد مالح

٩-لا يعطى المغمى عليه أي شيء من الفم

ما هو الخطأ الأكثر شيوعا في الإسعاف الأولي؟

إن المسعفين غير المتمرسين في الإسعاف الأولي غالبا ما تلفت انتباههم الإصابات الظاهرة مثل النزف والكسور البائنة. يجب أن لا تدع أي شيء يحول دون التأكد من سلامتك الشخصية أولا وقبل كل شيء والتأكد من أن المصاب في وضع آمن ومن ثم التحقق من أساسيات الإسعاف الأولي والتي تتمثل في التأكد من أن المجرى التنفسي للمصاب مفتوحا وبأن قلبه يعمل بشكل طبيعي.

تعد هذه من أهم الأمور الواجب التأكد منها وإتباعها، وهي مع الأسف، ما يهمله المسعفون الغير مدربين في الغالب.

لقد مات الكثير من المصابين من جراء انسداد المجرى التنفسي لديهم في الوقت الذي كان المسعفون يقومون بتجبير أطراف مكسورة لدى هؤلاء المصابين !! ان الكسور أمر غاية في الأهمية ولكنها لا تشكل خطرا مباشرا على حياة المصاب، صحيح أن المصاب يمكن أن يموت من جراء نزف من أحد شرايينه أو أوردته ولكنه يموت في وقت أقل من جراء انسداد مجراه التنفسي.

لا تكرر هذا الخطأ. لا تشتغل بأي شيء عن التأكد من أساسيات الإسعاف الأولي من حيث التنفس ونبض القلب

مبادئ الإسعاف الأولية

يعرف المسعف عن نفسه لتأمين حمايته وذلك بإبراز بطاقة أو شارة تدل على أنه مسعف مؤهل لتأدية التقنيات الإسعافية وإذا لم تتوفر البطاقة أو الشارة فهنا يتدخل المسعف كلاميا بحيث يدخل إلى مكان الحادث بقوة وبثقة وبالنفس فارضاً وجوده على الآخرين ويعرّف عن نفسه بصوت قوي وهادئ:

(مثلا : أنا مسعف في الهلال الأحمر قادر على مساعدة المصاب- أفسحوا لي الطريق)

تأمين السلامة: على المسعف تأمين سلامته الشخصية دائما في المقام الأول وذلك حتى لا يزداد وضع الحادث سوءا باحتمال وجود مصاب جديد، ثم عليه أن يخفف من المخاطر التي قد تطال المصاب أو المتجمهرين.

الاستفادة من وجود المتجمهرين: أحياناً يشكل وجود المتجمهرين حول المصاب عبئاً على المسعف أثناء أدائه للعمل الإسعافي وربما يكون ذلك من خلال تدخلهم العشوائي والغير منظم لمساعدة المصاب بدافع النية الطيبة والاندفاع للمساعدة، لذا يجب على المسعف أن يوجه هؤلاء المتجمهرين بما يخدم العملية الإسعافية وذلك من خلال:

الطلب منهم أن يقوموا بتأمين معدات لازمة للعمل (ضمادات - ألواح خشبية . . .).

أن يحضروا ماء مثلا أو أن يكلف أحدهم بعملية الإبلاغ.

أن يشبكوا أيديهم ويشكلوا دائرة حول المصاب.

طرق سحب المصاب:

ان القاعدة العامة تقضي بعدم تحريك المصاب من مكانه وتقديم الاسعافات اللازمة في مكان تواجده

الا أنه أحياناً يضطر المسعف الى اجلاء المصاب من مكانه وذلك لحمايته أو حماية المسعف لنفسه وذلك على اعتبار ان هذا أهون الشرين للابتعاد عن مصدر الخطر

ان سحب المصاب أمتارا قليلة قد تكفي لتحقيق مبدأ الحماية.

اجثُ خلف رأس المصاب.

ضع يديك تحت إبطيه وأمسك بملابسه أو تحت كتفيه بإحكام.

اجعل رأس المصاب يستند على ساعديك أو على الأرض برفق، واسحبه للخلف باتجاه مسار آمن مع تجنب ثني رقبته.

الحماية في الحوادث المختلفة

الحماية في حوادث الصعق الكهربائي:

يقطع المسعف التيار الكهربائي أو يطلب من أحد الأشخاص قطع التيار، لا يجوز للمسعف أن يقترب من المصاب وهو حافي القدمين أو يديه مبللتين، ثم يمسك بخشبة طويلة ويحاول إبعاد .المصاب عن مصدر الكهرباء

الحماية في حوادث الحرائق:

إبلاغ الجهات المختصة (الدفاع المدني–الإطفاء) وفي حال ضرورة التدخل لإخراج المصاب يبلل المسعف جسمه بالماء أو يلف جسمه ببطانية مبللة بالماء ثم يدخل إلى مكان الحريق زحفاً .أو بشكل القرفصاء لأن الأكسجين أثقل من بقية الغازات ويقوم بسحب المصاب

الحماية في حوادث الغرق:

الإبلاغ وطلب النجدة وعلى المسعف ألا يعرض حياته للخطر بالقفز خلف الغريق لأن إخراج الغريق يتطلب خبرة ولا يتدخل المسعف إلا إذا كان الغريق في مكان قليل العمق أو يكون قريباً منه بحيث يلقي إليه بعضاً أو حبل... (طريقة إسعاف الغريق في بحث اصابات الجهاز .التنفسي)

في حالات تسرب الغازات:

يمتنع المسعف عن الدخول لمكان التسرب الغازي إلا إذا كان محصوراً في غرفة فهنا عليه ألا يضغط على أي زر كهربائي أو استعمال الهاتف أو استعمال شمعة أو قداحة. يدخل المسعف إلى الغرفة وهو حابس تنفسه حيث يفتح النوافذ بسرعة ويخرج من الغرفة ليتنفس من جديد ثم .يدخل ثانية لسحب المصاب إلى الخارج بسرعة

حماية ممتلكات المصاب:

يجب الحفاظ على ممتلكات المصاب (محفظته- ساعته- حقيبته) وتسليمها لذويه أو للجهات المختصة (الشرطة مثلاً) أو للمشفى ويأخذ وصل استلام بذلك

فحص المصاب:

يقوم المسعف بإجراء فحص أولي للمصاب لمعرفة طبيعة الإصابة وذلك حسب التسلسل التالي:

فحص الوعي

عندما نصل إلى المصاب نتأكد فوراً من وعيه ومدى استجابته لردات الفعل (الصوت-الألم). إذا نستخدم في فحص الوعي: التنبيه الألمي + التنبيه اللفظي. على الشكل التالي:

نقوم بقرص الودابين مع استخدام التنبيه اللفظي حيث يصرخ المسعف باسم المصاب إذا كان يعرفه أو بسؤاله عن حاله وعما أصابه

وذلك أربع مرات

قرص الودابين (٤ مرات). .... فيك شي(٤ مرات)

إذا لم يستجب يكون عندها في حالة غيبوبة وفي حال استجابته نقوم باستجوابه وسؤاله عن ملابسات وظروف الحادث الذي تعرض له. أما عند الرضيع فيفحص الوعي بقرص حلمة الثدي أو كعب القدم ٤ مرات.

فحص التنفس:

إن فحص التنفس ضروري لدى المصاب بالغيبوبة وذلك لأنه عند حصول الغيبوبة يفقد الجهاز العصبي سيطرته الكاملة على كافة الأجهزة والأعضاء ومنها الجهاز العضلي فيحدث ارتخاء عضلي وما يهمنا هنا هو ارتداد قاعدة اللسان وإغلاقها للمجرى التنفسي لذا وجب فحص الوظيفة التنفسية وتفقده. **الطريقة:** يعمل المسعف على تحرير المسالك التنفسية بإمالة الرأس إلى الوراء وذلك بأن يضع إحدى يديه على جبين المصاب ويستخدم إصبعين من اليد الأخرى يوضعان على عظم الذقن(السبابة والوسطى)، كما يفك زر القميص وكذلك ربطة العنق والحزام.

لفحص الوظيفة التنفسية وذلك بأن (C.L.F) (Check – Listen – feel) يطبق المسعف تقنية يضع أذنه فوق فم وأنف المصاب وهو ينظر إلى حركة الصدر والبطن.

يرى: يلاحظ المسعف حركة الجزء الأعلى من البطن وحركة الصدر.

يسمع: يسمع إذا كان الهواء يدخل ويخرج مع كل حركة تنفسية.

يشعر: يشعر بسخونة هواء الزفير الخارج من المريض واصطدامه بوجه المسعف.

تفحص الوظيفة التنفسية ما بين ٥–١٠ ثواني. وفي حال كان المكان الموجود فيه المصاب مظلماً يضع المسعف يده على صدر المصاب عند تطبيق C.L.F.

أما عند الرضيع: يتم أولاً تحرير المسالك التنفسية وذلك بوضع منشفة أو ضمادات بين كتفي الرضيع، وذلك لأن كتلة الرأس عند الرضيع كبيرة فلا يمكن إمالته للخلف وتركه حيث يعود مباشرة إلى وضعه الأولي، ثم تطبق تقنية C.L.F.

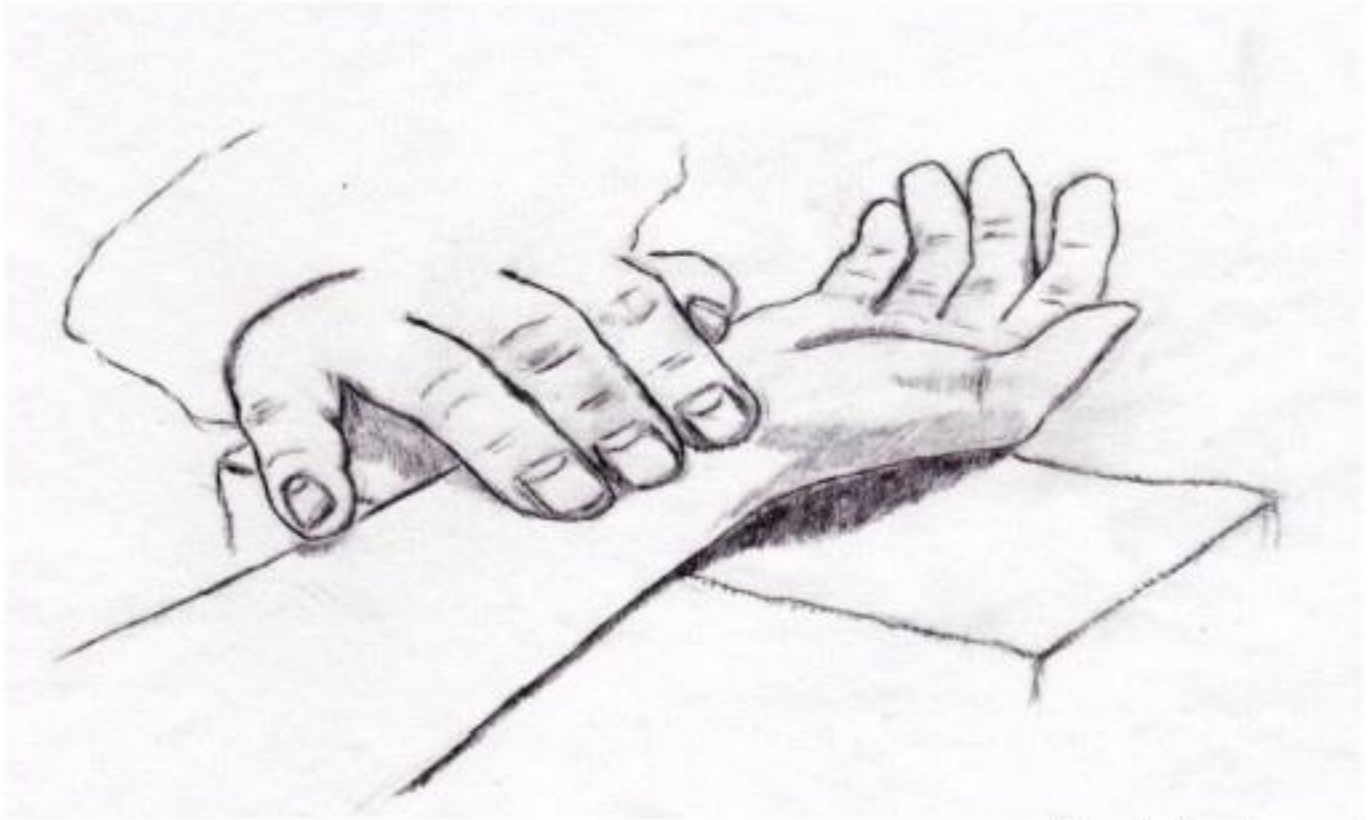
فحص النبض.

إن النبض الشرياني هو انعكاس لعمل القلب، فالقلب ينقبض وينبسط (يخفق) عدة مرات وهذه الخفقات تختلف حسب العمر وحسب الجنس وتخضع للعوامل الخارجية (رياضة-تعب) والداخلية (المرض) وكل خفقة تنتقل إلى الشرايين الرئيسية التي نستخدمها لقياس النبض .

يجب عند قياس النبض أن ننتبه إلى عدة أمور :الانتظام – السرعة – التواتر .

يفحص النبض عند البالغ من الشريان السباتي في العنق بوضع السبابة والوسطى فقط دون الإبهام على مسار الشريان لمدة ٥ ثواني إذا لم نجد النبض نقيسه من الجهة الأخرى لمدة ٥ ثواني أيضاً.

يمكن قياس النبض من الشريان الكعبري في المعصم إلا أن السباتي أفضل. وعند الرضيع يقاس النبض بنفس طريقة السابقة ولكن من بين حلمتي الثدي



فحص الجهاز الدوراني.

لملاحظة وجود نزيف عند المصاب، قد يكون النزف ظاهر وقد يكون باطن أي لم يظهر فوق .ثياب المصاب، كما يتم فحص أسفل المصاب فقد يكون النزف غير ظاهر للعيان

فحص الجهاز المحرك

يتم فحص وجود كسور أو خنوع عند المصاب وذلك بجس العظام بواسطة أصابع المسعف .وذلك بهدوء ولطف حتى لا نؤلم المصاب

بعد أن يتم فحص المصاب بالتسلسل السابق يتم أيضاً تحديد عدد الإصابات ونوعية الإصابة وأماكن وجود الإصابات

نقل المصاب إلى المشفى مع مراقبة الوظائف الحيوية

ينقل المصاب إلى المشفى حسب أولوية النقل في حال تعدد الإصابات، فقد لا تكون سيارات الإسعاف كافية لنقل المصابين جميعهم دفعة واحدة والأطباء هم يقررون أولوية النقل، مع العلم .أن أولوية النقل تختلف حسب الحالة

أثناء نقل المصاب إلى المشفى يلتزم المسعف بمراقبة الوظائف الحيوية لدى المصاب من أجل .التدخل السريع في حال حدوث أي خلل في أحدها

مراقبة الوعي

.قرص الودابين عند الكبار أو حلمة الثدي عند الصغار مع التنبيه اللفظي

.الاستجابة للألم. ردات فعل الجسم

فحص التنفس

.يراقب انتظام عملية التهوية وتواترها .C.L.F تتم بتحرير المسالك التنفسية مع طريقة

فحص النبض

يفحص النبض من خلال الطريقة المشروحة سابقاً (يفحص وجود النبض) كما يراقب مواصفات النبض هل هو بطيء أو سريع، سطحي أو عميق

فحص العين

يراقب البؤبؤين لأن اتساعهما يدل على عدم وصول الأكسجين إلى الدماغ كما يراقب حركة الترميش – لون صلبة العين.

العين السوداء هي نتيجة حدوث نزيف تحت الجلد المحيط بالعين قد يكون مصاباً بكسر في الجمجمة لو كنت تشعر بالرؤية المزدوجة.

فحص الجلد

يراقب لون الجلد (الازرقاق يدل على الاختناق).

الجفاف أو التعرق (التعرق البارد دليل وجود الصدمة حرارة الجسم

فحص الأذن

يراقب خروج سائل زهري (دليل نزيف داخلي في الرأس)، أو خروج دم (دليل وجود جرح خارجي في الأذن)

فحص الأنف

يراقب خروج دم أو سائل مخاطي .تراقب عملية التهوية من خلال الأنف.

فحص الفم: تراقب عملية التهوية - يراقب خروج دم أو إقياء أو لعاب.

يراقب خروج أصوات (الغرغرة) - يراقب لون الشفتين.

بعد أن يقوم المسعف بالخطوات السابقة ويسلم المصاب إلى الطبيب الأخصائي ويشرح له حالة المصاب والإسعافات التي قدمها له فهنا تنتهي مهمة المسعف.

فحص الوجه

ينظر المسعف إلى لون وجه المصاب، فقد يكون مصفراً أو شديد الاحمرار وربما كان مائلاً إلى الزرقة إذا كان التنفس متأثراً بالإصابة. وفي الوقت نفسه يتحسس المسعف حرارة وجه المصاب هل هو ساخن أو بارد مع ملاحظة حالة الجلد هل هو جاف أو ندي أو يعرق بغزارة.

فحص الجمجمة:

يمرر المسعف يده بلطف فوق فروة رأس النصاب بحثا عن أي نزف أو تورم أو أي أثر يدل عللى وجود كسر

فحص الصدر:

يفحص المسعف أضلاع الصدر للتأكد من استواء وضع حركة الأضلاع في أثناء التنفس ويلاحظ عدم وجود أي جرح يمتص الهواء، ثم يفتش في الأضلاع عن أي بروز أو انخفاض يمكن أن يدل على وجود كسر كما يتحسس عظم القص أيضاً.

فحص الترقوة:

يفحص المسعف الترقوتين ويفتش عن عدم الانتظام فيهما ويُفحص الكتفين للبحث عن علامات تشوه فيهما.

ويتحسس الحوض من الجانبين بعناية ويبحث عن عدم وجود كسر كما يلاحظ أية علامة تدل على سلس في البول أو البراز

فحص الطرفين العلويين

يفحص المسعف عظام العضدين، ثم عظام الساعدين والرسغين واليدين والأصابع ويفتش بعناية عن وجود أي تشوه في الشكل أو تورم يدل على كسور. ويفتش في الساعدين عما إذا كان المصاب يلبس سواراً طبيّاً تحذيرياً لإصابته بداء السكري أو يحمل علامات حقن قد تدل على إدمان على المخدرات.

فحص الطرفين السفليين

يفحص المسعف الوركين والفخذين والرضفتين وعظم الركبتين وعظمتي كل ساق والكاحلين والقدمين وأصابعهما بطريقة فحص الذراعين نفسها



.

كيفية إجراء الفحص

يجب إجراء فحص عام للمصاب، وذلك لاكتشاف أي تهديد محتمل الحدوث لحياته سواء كان المصاب واعياً أم فاقداً للوعي. فعندما يقوم المسعف بفحص المصاب **يجب إتباع ما يلي:**

عدم تحريك المصاب كثيراً تحاشياً لتفاقم الإصابة

الفحص بدءاً من الرأس وانتهاءً بالقدمين

استعمال كل الحواس: النظر، والسمع، و اللمس، والشم

المقارنة دائماً بين جانبي جسم المصاب، لأن ذلك يسهل البحث عن أي تورم أو تشوه يحتاج إلى إسعاف اولي.

العوامل المساعدة على التشخيص.

وقائع الحادث :يعتمد التشخيص على معلومات تؤخذ من الظروف المحيطة ومن المصاب نفسه، ومن المارة: فتسجيل وقائع الحادث. يؤدي سؤال المصاب عن الأعراض وفحصه للبحث عن العلامات إلى التشخيص الدقيق. والجدول الآتي يبين عناصر التشخيص

الأعراض التي يشعر بها المصاب عند سؤاله

الألم -فقدان الحركات الطبيعية - فقدان الإحساس - البرودة - الحرارة - العطش الغثيان- الضعف-فقدان الذاكرة -الإغماء -الدوار -فقدان الوعي المؤقت -الإحساس بكسر العظم

الملاحظة بالنظر

التنفس - نوع وكمية النزف - الجروح - الأجسام الغريبة - لون الوجه -التورم -تشوه الشكل الكدمات -السلس -الأفعال اللإرادية -الاستجابة للمس -القيء -آثار الإبر

الملاحظة باللمس

:الرطوبة -الحرارة -النبض -التورم -الانتفاخ -تشوه الشكل -عدم الانتظام- التألم باللمس.

الملاحظة بالشم.

الغاز الكحول .الاحتراق .النفس .

الملاحظة بالسمع

القرقة العظمية- الأنين- .النفس .

العلامات الخارجية

إذا كان المصاب فاقداً وعيه يفتش المسعف جيوبه وحقيبة يده أو محفظة أوراقه للبحث عن أي شيء يساعد على فهم وضعه الصحي. فبطاقات مواعيد المستشفى أو العيادات أو بطاقات المعلومات قد تكشف أنه مصاب بالسكري أو أي مرض آخر، أو أنه يتعرض لنوبات صرعية. .كما أن العثور على قطع السكر أو الجلوكوز يدل على أنه يعاني من داء السكري

ثمة العديد من وسائل التحذيرات الطبية يحملها الأشخاص الذين لديهم مشكلة طبية، وتكون بشكل ميدالية أو سوار توضع في الرسغ أو حول العنق أو في سلسلة المفاتيح وتحتوي على .قصاصة ورق تصف حالة المريض

لهذا يجري البحث عنها وتحميلها إلى الشرطة أو رجال الإسعاف لأنها تفيد في التعرف على حالة المصاب الصحية وتسرع في علاجه



الاختناق

كيف أتصرف لإنقاذ شخص انسد المجرى التنفسي لديه

(أ) انسداد المجرى التنفسي باللسان: إذا كان الإنسان فاقداً للوعي ومستلقٍ على ظهره فتجب مساعدته للحيولة دون انسداد مجراه التنفسي بلسانه، ويتمثل ذلك في استخدام أسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن، وبما أن اللسان متصل بالفك فإنه عندما يتم رفع الفك إلى أعلى يرتفع معه اللسان وبذلك يبقى المجرى التنفسي مفتوحاً.

(ب) انسداد المجرى التنفسي بواسطة جسم غريب: إن كيفية التصرف إزاء وجود جسم غريب في المجرى التنفسي يعتمد على كون المصاب في وعيه أم فاقداً للوعي:

بالنسبة للشخص الذي يكون في وعيه: هل انسداد المجرى التنفسي لديه كامل ام جزئي؟

إذا كان بإمكان المصاب أن يتكلم أو يسعل يكون انسداد المجرى التنفسي لديه جزئيا. في هذه الحالة لا تفعل له شيئاً سوى تشجيعه على السعال ومحاولة فتح مجرى تنفسه بنفسه. ابق معه لتساعده في حال ساءت حالته.

إذا لم يكن باستطاعة المصاب التكلم أو السعال فهذا يعني أن المجرى التنفسي لديه مغلق تماماً والمصاب في هذه الحالة بحاجة ماسة للمساعدة وبسرعة. ويترتب عليك في مثل هذه الحالة أن تضرب براحة يدك على ظهره عدة مرات أو تقوم بالضغط على منطقة بطن المصاب حيث أن الضغط على البطن من شأنه أن يجبر الهواء الموجود في الرئتين إلى الخروج دافعاً أمامه الجسم الغريب الذي يسد المجرى التنفسي.

كيف أنقذ مصاباً بانسداد المجرى التنفسي

١-اسأل المصاب"هل تختنق ؟ "

٢- إذا لم يتمكن المصاب من الإجابة على سؤالك، قم بالضغط على منطقة بطن المصاب ويمكن وصف هذا الأجراء على النحو التالي:

أ- اقبض إحدى يديك على شكل قبضة محكمة.

ب- قف خلف المصاب وأحطه بذراعيك بحيث تكون قبضة يدك على بطن المصاب (فوق السرة بقليل) ويكون إبهام قبضة يدك باتجاه بطن المصاب.

ج- أقفل ذراعيك بشكل محكم ثم اضغط على منطقة بطن المصاب مع مراعاة أن يكون الضغط إلى الداخل والى الأعلى في آن واحد.

٣-استمر في إجراء الضغط بشكل متقطع إلى أن يتم خروج الجسم الغريب من المجرى التنفسي، أو إلى أن يفقد المصاب وعيه بسبب عدم خروج هذا الجسم الغريب.

٤-إذا فقد المصاب وعيه أنزله على الأرض وحاذر أن يرتطم رأسه بالأرض.

٥-استدع سيارة الإسعاف فوراً بالاتصال على رقم الطوارئ.

٦-استخدم أسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن. افتح فم المصاب وأدخل إصبعك وحاول إزالة الجسم الغريب الذي تسبب في انسداد المجرى التنفسي.

٧-المجرى التنفسي وحاول إعادة التنفس الطبيعي لدى المصاب عن طريق إجراء التنفس الصناعي.

٨-إذا لم يدخل الهواء إلى رئتي المصاب بعد إجراء التنفس الصناعي فذلك يعني أن



المجرى التنفسي لا يزال مسدوداً، في هذه الحالة أعد الخطوات المتبعة في (٦) و (٧) أعلاه ثلاث مرات.

٩-إذا لم يتم خروج الجسم الغريب من المجرى التنفسي بعد تلك المحاولات، أبدأ في إنقاذ المصاب من خلال الضغط على عظم الصدر (كما في حالات إنعاش القلب والرئتين).

١٠-استمر في محاولة إنقاذ المصاب إلى أن تصل سيارة الإسعاف أو إلى أن يتم خروج الجسم الغريب من المجرى.

١١-إذا خرج الجسم الغريب من المجرى التنفسي ، قم بفحص التنفس ونبض القلب تماما كما تفعل في حالة إنقاذ المصاب بتوقف القلب أو / و الرئتين.

التنفس الصناعي (قبلة الحياة):

يوضع المصاب على ظهره مع ثني الرأس إلى الوراء بحيث تتجه فتحتي الأنف إلى الأعلى ندفع الفك السفلى إلى أعلى بحيث تبرُز الذقن لأن هذا يمنع اللسان من إغلاق القسم الخلفي من الحلق.

يتم تفريغ الفم من كل شيء فيه حتى الأسنان الصناعية. إليك النص المستخرج من الصورة بالكامل:

باليد اليسرى تضم فتحتي الأنف وجذب الرأس إلى الوراء وباليد اليمنى نبقى الذقن متجها إلى الأعلى

خذ نفسا عميقا وأطبق شفتيك بإحكام حول فم المصاب

أنفخ بلطف وثبات إلى داخل الفم والرئتين ثم أدر رأسك لاستنشاق هواء جديد والتحقق من أن رأس المصاب يرتفع ثم ينخفض مع خروج الهواء من رئتيه فإذا لم يكن كذلك فلنفحص مسالك الهواء مرة أخرى ونستمر بالنفخ حتى يتم تزويده بالأوكسجين بأسرع ما يمكن

نتابع النفخ مرة كل ٥ ثواني

حالما يستعيد المصاب تنفسه لا نتركه وحده بأي حال من الأحوال .



ماهو وضع الإنقاذ للمصاب بانسداد مجرى التنفس؟

هو الوضع الآمن والمستقر الذي يوفر الحماية للمجرى التنفسي للمصاب الفاقد الوعي. عند وضع المصاب الفاقد للوعي بشكل يكون فيه شبه منكب على وجهه لن يرتد اللسان إلى الخلف ليسد مجرى التنفس، كما أن القيء والافرازات المخاطية لن تدخل إلى المجرى التنفسي بل ستخرج من الفم.

كيف تضع المصاب في وضع الإنقاذ؟

لوضع المصاب في وضع الإنقاذ يجب إتباع الخطوات التالية:

١-ضع المصاب مستلقيا على الأرض.

٢-ارفع الذراع اليسرى للمصاب إلى أعلى بزاوية قائمة.

٣-ضع اليد اليمنى للمصاب على خده الايسر بحيث يكون باطن يده إلى الخارج.

٤-اثن ركبة المصاب اليمنى إلى أعلى بزاوية قائمة

٥-أدر المصاب باتجاهك وضعه على جنبه الايسر وذلك بسحبه من ركبته اليمنى وكتفه الأيمن.

٦-تأكد من أن المصاب في وضع مريح.

اسعاف شخص توقف قلبه

.تعتمد إمكانية إنقاذ إنسان توقف قلبه على أول شخص شاهد ما قد حدث
كل دقيقة تمر على المصاب دون إسعاف تقلل من فرص هذا المصاب في النجاة أو البقاء على قيد الحياة، لذا فإن الوقت هنا يعني الفرق بين الحياة والموت
إن دماغ الإنسان وقلبه لا يستطيعان تحمل انقطاع الدم والأوكسجين عنهما لأكثر من (٦) ستة دقائق حيث أن خلايا الدماغ والقلب تبدأ بالموت بعد مرور هذه الدقائق الستة
تجدر الإشارة إلى أنه حتى في الدول المتقدمة فإن وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الشخص المصاب يستغرق فترة ٨ إلى ١٠ دقائق
قد تعتمد حياة إنسان على ما يمكن أن يقدمه له من عون، ولا يقتصر ثواب إنقاذ حياة إنسان على الثواب في الدنيا فالله يجزيك خير الجزاء لعظم هذا العمل عند الله حيث يقول في كتابه الكريم"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"

ما هو الإنعاش القلبي الرئوي؟

الإنعاش القلبي الرئوي: هي عملية مزدوجة يقوم المسعف فيهما بإنعاش الرئة والقلب
أما إنعاش الرئة فيتم من خلال إيصال الهواء والأوكسجين إليها عن طريق التنفس الصناعي، وأما إنعاش القلب فيتم عن طريق الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب (في المنطقة الواقعة بين العظم الصدري والعمود الفقري) بحيث يتم ضخ الدم إلى الأجزاء الحيوية من جسم المصاب، خصوصاً الدماغ



لماذا تعتبر عملية الإنعاش القلبي الرئوي هامة جداً؟

عملية الإنعاش القلبي الرئوي بحد ذاتها تعتبر عملية لكسب الوقت بحيث يتم تزويد الرئة بالأوكسجين والقلب بالدم إلى حين وصول سيارة الإسعاف، وبذلك تكون فرص المصاب في البقاء على قيد الحياة قد زادت. وفي حالة بقاء المصاب بدون إسعاف أولي فان دماغه يبدأ بالموت في فترة زمنية تتراوح من ٤ إلى ٦ دقائق، ولكن ينبغي أن نعرف بأن الإنعاش القلبي الرئوي وحده لا يمكن أن ينقذ حياة المصاب إنما هو واحد من سلسلة من الإجراءات الواجب إتباعها والتي تشمل العناية الطبية التي تقدم عن طريق الطاقم الطبي في سيارة الإسعاف وعن طريق الأطباء في المستشفى، لذا فان طلب العناية الطبية / استدعاء سيارة الإسعاف في وقت مبكر يعد ضروريا للغاية.

كيف تقوم بإسعاف / إنعاش المصاب بتوقف القلب أو الرئتين؟

١-تأكد من انك في وضع آمن إذا اقتربت من المصاب، احذر أن تصبح أنت نفسك مصابا.

٢-حاول معرفة ما إذا كان المصاب قادرا على الاستجابة أم لا، وحاول إيقافه عن طريق هز كتفيه ومناداته بصوت مرتفع وعلى مقربة من أذنيه.

٣-اطلب النجدة ممن هم حولك أو من المارّة، اطلب النجدة حتى ولو كنت لا ترى أحدا بالقرب منك. إذا استجاب أحد لطلب النجدة أطلب منه أن ينتظر بالقرب منك إلى أن تقوم بتقييم حالة المصاب.

٤-ضع المصاب على الأرض أو سطح صلب وقم بإزالة أية وسائد تكون تحت رأسه. كن حذرا في حالة تعاملك مع مصاب كان قد فقد وعيه اثر ارتطامه بشيء.

٥-تأكد من أن المجري التنفسي مفتوحاً، استخدم أسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن. وللتأكد من ان المجرى التنفسي مفتوحا، اتبع الخطوات التالية:

.أ- ضع إصبعين من أصابع أحد يديك تحت ذقن المصاب وارفع رأسه إلى أعلى

.ب- ضع راحة يدك الأخرى على جبين المصاب ثم اضغط إلى أسفل

ج- أنظر داخل فم المصاب للتأكد من خلو فمه من أي جسم غريب أو أسنان صناعية (طقم .أسنان) أو مخلط

د- إذا كان المصاب يعاني من أثر صدمة أو رضوض فان عليك أن تتجنب تحريك رقبته .وحاول فتح المجرى التنفسي بأسلوب الضغط على الفك

٦-تحقق ولمدة ١٠ ثوان فيما اذا كان المصاب يتنفس أم لا وذلك بالطرق التالية بتطبيق قاعدة: هل يتنفس المصاب أم لا ؟

أ- إذا كان المصاب يتنفس ضعه في وضع الإنقاذ وانتظر سيارة الإسعاف

ب- إذا كان المصاب لا يتنفس:

اطلب من الشخص الذي يقوم بمساعدتك أن يستدعي سيارة إسعاف وان يعود إلى حيث أنت في أسرع وقت ممكن، وإذا لم يكن هناك شخص ليساعدك اذهب واستدع سيارة الإسعاف بنفسك قم بإجراء التنفس الصناعي بالنفخ في فم المصاب مرتين ببطء بطريقة ما يسمى (قُبْلَة الحياة) وذلك على مدى ثانية ونصف إلى ثانيتين، راقب ارتفاع صدر المصاب بعد النفخ في فمه وانتظر حتى يهبط صدره بين النفخة الأولى والثانية.

٨-إذا كنت مدربا على جس النبض السباتي فافعل ذلك لمدة ١٠ ثوان وذلك على النحو التالي: .
قم بتحسس مكان الحنجرة (تفاحة آدم) في الرقبة وذلك باستخدام إصبعين من أصابع يدك.
مرر إصبعك في المجرى المحاذي للحنجرة واضغط قليلاً لجَس النبض، أما إن لم تكن مدربا على جس النبض فابحث عن أية علامة من علامات الحياة على المصاب.
٩-هل هناك علامات تدل على أن المصاب لا يزال على قيد الحياة أو أن قلب المصاب لا يزال ينبض؟
إذا كانت الإجابة بنعم فعليك الاستمرار في محاولة إنقاذ المصاب بإعطائه تنفساً صناعياً مرة كل (٥) خمس ثوان إلى حين وصول سيارة الإسعاف.
إذا كانت الإجابة بلا فعليك المباشرة بما يلي:
١٠-اضغط على صدر المصاب بهدف إعادة قلبه إلى العمل بواقع ١٥ خمس عشرة مرة -10 وذلك بإتباع ما يلي:
تحسس الحد الخارجي للضلع السفلي للمصاب وذلك بوضع يديك على جانبي قفصه الصدري.
تتبع بأصابع يدك حدود الأضلاع السفلى إلى أن تلتقي أصابعك عند عظم صدر المصاب.
ضع إصبعك الوسطي (من يدك الواقعة باتجاه قدمي المصاب) على عظم الصدر ثم ضع إصبعك الشاهد إلى جانب الإصبع الوسطي.
ضع راحة يدك الأخرى على عظم صدر المصاب مكان الإصبعين الوسطي والشاهد.
ضع يدك الأخرى فوق راحة يدك جاعلا كلتا يديك في وضع تشابك.
اجعل جسمك في وضع يكون فيه كتافك وكوعاك بشكل عمودي بالنسبة ليديك، تأكد ان ذراعيك وظهرهك في وضع استقامة ثم باشر في إجراء الضغط على عظم صدر المصاب مستخدماً عضلات ظهرك وليس عضلات ذراعيك.
اضغط على عظم الصدر إلى أسفل بواقع ٤ إلى ٥ سم وبمعدل ٨٠ إلى ١٠٠ مرة في الدقيقة
١١-قم بإعطاء التنفس الصناعي مرتين، استمر في إعطاء دورة الدقيقة الواحدة من التنفس الصناعي.(أي ٤ دورات في كل منها ١٥ ضغطة لإنعاش القلب ونفختان اثنتان لإنعاش الرئتين)ثم افحص النبض.
إذا لم يكن هناك نبض استمر في عملية الإنقاذ إلى حين وصول سيارة الإسعاف مع الاستمرار في تفقد النبض كل بضعة دقائق.



الغصة

الغصة :هي انسداد مجرى الهواء بجسم غريب أو قطعة طعام، مما يؤدي لتوقف التنفس و فقدان الوعي.

الأسباب المؤدية للغصة:

١-محاولة بلع قطع كبيرة من الطعام دون مضغها جيدا

٢-شرب المواد الكحولية والمواد المخدرة قبل الأكل أو أثنائه "المواد الكحولية تخدر وتضعف العضلات المساعدة على البلع"

٣-استعمال أطقم أسنان صناعية، فالأسنان الصناعية تجعل من الصعب الإحساس بحجم اللقم أثناء المضغ والبلع.

٤-التكلم بانفعال أو الضحك أثناء الأكل بسرعة.

٥-المشي أو اللعب أو الركض مع وجود أشياء داخل الفم.

أنواع الغصة:

١-انسداد مجرى الهواء الجزئي.

عندما يعاني المصاب من انسداد مجرى الهواء الجزئي فإنه يستطيع أن يسعل بقوة في محاولة لإزالة الجسم الذي يسد مجرى الهواء و قد يستطيع الكلام. كما أن تنفسه يكون بصوت عالٍ ويشبه الصفير، وقد يمسك المصاب عنقه دلالة علي وجود جسم غريب يسد مجرى الهواء، في هذه الحالة لا تتدخل وشجع المصاب على الاستمرار في السعال. إذا استمر السعال اتصل بقسم الطوارئ.

٢-انسداد مجرى الهواء الكلي:

قد يتحول انسداد مجرى الهواء الجزئي إلى انسداد كلي لمجرى الهواء، وفي هذه الحالة لا يستطيع المصاب الكلام أو التنفس أو السعال. في بعض الأحيان قد يسعل المصاب سعالا ضعيفا وغير فعال، وقد يصدر عن تنفسه أصوات حادة، في هذه الحالة أطلب من أحد المتواجدين الاتصال بقسم الطوارئ وابدأ فورا بتقديم الإسعاف الأولي.

الإسعاف الأولي:

أولا-إذا كان المصاب واعيا:

اسأله هل أنت غاص ؟ فإذا كان يعاني من الغصة ابدأ فورا بتقديم الإسعاف الأولي وأجل المصاب ينحني للأمام ثم اضغط أربع ضغطات بقبضة يدك تحت الصدر وفوق السرة على أن يكون اتجاه الضغط إلى أعلى في اتجاه الصدر.استمر في ضغطات البطن بنفس الطريقة حتى يتحرك الجسم الغريب ويلقى به من الفم أو يبدأ المصاب في السعال.عندئذ أوقف الضغطات وراقبه فقط .

ثانيا-إذا كان فاقداً للوعي:

حاول فتح مجرى الهواء وافحص التنفس فإن انعدم التنفس أعطه تنفسا اصطناعيا فإذا وصل الهواء إلى الرئتين (يعلو الصدر وينخفض) أعطه نفختان سريعتان ثم أفحص النبض و التنفس. أما إذا لم يصل الهواء إلى الرئتين اضغط أربع ضغطات على البطن و كرر العملية حتى يفتح

مجرى الهواء وتخرج القطعة العالقة، ثم أعطه تنفسا اصطناعيا أو إنعاش كامل للقلب والرئتين .إن لزم الأمر

حالات خاصة:

في بعض الحالات قد لا تستطيع لف ذراعيك حول بطن المصاب وذلك قد يكون بسبب سمنة زائدة عند المصاب أو كون المصاب أمراءه حاملا فيكون الضغط على الصدر بالشكل التالي:

١-خلف المصاب ولف ذراعك تحت إبطيه وحول صدره

٢-ضع قبضتك من جهة الإبهام على وسط عظم صدر المصاب (عظمة القص)

٣-أمسك قبضتك بيدك الأخرى.

٤-اضغط على الصدر بشدة أربع مرات إلى أن يفتح مجرى الهواء.

ثالثا-إذا كنت بمفردك وأصبت بغصة:

أصبت بغصة ولا يوجد حولك من يساعدك فإنك تستطيع إجراء الضغطات البطنية لنفسك كمايلي:

ضع قبضة يدك من جهة الابهام على وسط البطن فوق السرة بقليل وتحت الطرف السفلي لعظمة الصدر.

أمسك قبضة يدك بيدك الأخرى وأعط ضغطات سريعة.

تستطيع كذلك الانحناء للأمام وضغط بطنك على حافة جسم ثابت مثل ظهر كرسي أو غيره.



رابعا-إذا كان المصاب طفلا رضيعا:



الربو الشعبي

هو مرض صدري مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين حيث تضيق فيه المجاري التي تحمل الهواء من وإلى الرئة وبالتالي يصعب التنفس. مجاري الهواء في الشخص المصاب بالربو تكون شديدة الحساسية لعوامل معينة تسمى المهيجات وعند إثارتها بهذه المهيجات تلتهب مجاري الهواء وتنتفخ ويزيد إفرازها للمخاط وتتقبض عضلاتها ويؤدي ذلك إلى إعاقة التدفق العادي للهواء، وهذا ما يسمى بنوبة الربو.

أعراض مصاب الربو:

ضيق و صعوبة في التنفس و تعثر في الكلام.
الشعور بالقلق و الخوف.
تعذر الكلام.
ازرقاق و خاصة الوجه.
ظهور عرق.
هيجان و سعال شديد.
أحيانا بخروج قشع مخاطي من انف المريض.
الزفير أطول من الشهيق مع صعوبة أثناء الزفير.
حدوث امتلاء في الأوردة العنقوية.
يكون صوت الزفير مسموعا مع سماع خرخرة قصبية أثناء الزفير.
تشترك جميع العضلات التنفسية بعملية التنفس.
سرعة في النبض.
حدوث ارتفاع في التوتر الشرياني.

الإسعاف الأولي لمرضى الربو

١-التخفيف عن المصاب وتهدئته والتحدث معه.
٢-جلوس المصاب مع مد رجليه و استناد الجزء العلوي من الجسم على يديه خلف جسمه.
٣-خلع الملابس الضيقة لتسهيل عملية التنفس.
٤-Ventolin يعطى المصاب بخاخ.
٥-إعطائه أكسجين .
٦-إعطائه سوائل على الدوام.
٧-فحص الحالة العامة للمريض و مراقبة تنفسه و نبضه و ضغطه بشكل مستمر.
٨-ينقل المصاب إلى المستشفى.

النزيف

يتم انتقال الدم في جسم الإنسان عبر الأوعية الدموية، والتي تقسم إلى ثلاثة أقسام: (الشرايين - الأوردة - الأوعية الدموية الشعرية)، حيث يقوم الدم بحمل الأوكسجين إلى خلايا الجسم التي تستخدم الأوكسجين كوقود لها، وبدون الأوكسجين لا يمكن لأعضاء الجسم وأنسجته أن تعمل. فإذا نزف الدم من جسم الإنسان واستمر النزف لفترة طويلة فلن يبقى في الجسم دم كاف لنقل الأوكسجين إلى الخلايا، وفي حالة نقص الأوكسجين فان بعض الأعضاء الحساسة والحيوية في الجسم مثل الدماغ والقلب سيصيبها التلف، لهذا كان وقف النزف على قدر كبير من الأهمية.

هل النزف من مختلف الأوعية الدموية متساوي؟

بالطبع لا. تختلف درجة خطورة النزف تبعا لنوع الوعاء الدموي النازف، كما تختلف طريقة النزف من كل نوع من أنواع الأوعية الدموية حيث أن كل منها يكون تحت درجة ضغط مختلفة عن الآخر، ويكون الاختلاف في النزف على النحو الآتي:

الشرايين:

الشرايين أوعية ذات أنسجة عضلية قوية تقوم بنقل الدم الغني بالأوكسجين من القلب إلى مختلف أعضاء وأنسجة الجسم، وحيث أن الدم الذي يجري فيها قادم من القلب مباشرة فان ضغه يكون عاليا، ويسير الدم في الشرايين على شكل نبضات مع كل ضربة من ضربات القلب، وفي حالة حدوث قطع في أحد الشرايين فان الدم ينزف من الجرح على شكل نبضات من شدة الضغط الواقع عليه. ويعتبر النزف في هذه الحالة خطيرا لذا فانه يجب وقف النزف فور التأكد من عمل القلب والرئتين وتولي أمرهما، ونظرا لارتفاع ضغط الدم في الشرايين فان الجسم يمكن أن يفقد معظم الدم إذا لم يتم وقف النزف الشرياني.

الأوردة:

تقوم الأوردة بنقل الدم من مختلف أعضاء الجسم إلى القلب. والأوردة ليست بقوة الشرايين، ثم إن الدم فيها لا يكون تحت ضغط عال. ويكون النزف من الأوردة (النزف الوريدي) على شكل دفق ثابت وليس على شكل دفقات نبضيه. ويعتبر النزف الوريدي أقل خطورة من النزف الشرياني، ويتوقف النزف الوريدي تلقائيا بعد فترة تتراوح بين ٦ و ٨ دقائق، ويستثنى من هذه القاعدة بالطبع النزف الناجم عن جرح قطعي في وريد كبير الحجم.

الأوعية الدموية الشعرية:

الأوعية الدموية الشعرية أوعية صغيرة الحجم ودقيقة وتصل بين الشرايين والأوردة، وينتقل الأوكسجين عبر هذه الأوعية إلى خلايا الجسم كما تقوم بنقل الفضلات – مثل ثاني أكسيد الكربون – من الخلايا إلى الدورة الدموية. إليك النص الموجود في الصورة كاملاً وبشكل منسق:

المعهد التقاني الصحي بحمص – فرع المخبر– السنة الثانية– الأسعاف الأولي – المحاضرة الثانية

ويكون النزف الوعائي الشعري على شكل ترشيح بطيء غير متدفق وهو لا يعتبر نزفا خطرا أو مميتا لذا فان من الممكن إرجاء معالجته إلى حين الانتهاء من الجوانب الأكثر أهمية.

ويتوقف هذا النوع من النزف تلقائيا بعد مرور ٢ – ٣ دقائق، وتجدر الإشارة إلى أن معظم حالات النزف التي يواجهها المسعفون هي من النوع الوعائي الشعري.

خطوات وقف النزف:

يتم وقف ٩٩ % من حالات النزف بالضغط على مكان النزف باستخدام ضمادة ماصة. فما هي الضمادة؟

الضمادة هي قطعة من أية مادة يمكن وضعها على الجرح لوقف النزف، والضمادة المثالية التي يمكن استخدامها تكون مصنوعة من الشاش الطبي الذي يتميز بخاصية امتصاص السوائل وعدم الالتصاق بالجرح، ولكن الحوادث والإصابات لا تقع دائما في أماكن توفر فيها الضمادات المثالية. في الحالات التي لا تتوفر فيها ضمادات طبية يمكن استخدام مادة بديلة بشرط أن تكون نظيفة وتتميز بخاصية عدم الالتصاق بالجرح. ويمكنك كمسعف أن تستخدم أقمشة الملابس أو المناشف أو أغطية الأسرة كضمادات للجروح النازفة، أما المحارم الورقية أو ورق التواليت فهي ليست خيارا جيدا للاستخدام كضمادات وذلك لان هذه المواد تفتت عندما تبتل، كما تلتصق بالجروح الأمر الذي قد يؤدي إلى تلوث الجروح والتهابها ويجعل تنظيف الجروح فيما بعد أمرا معقدا.

ما هي عصابة التضميد؟

التضميد هي أية مادة تستخدم لربط الضمادة فوق الجرح النازف. هناك لفافات خاصة مصممة لربط الضمادات فوق الجروح، ولكن في غياب هذه اللفافات الطبية الخاصة يمكن استخدام وسائل ربط أخرى مثل ربطات العنق (الكرافات) أو الغترة أو حتى الأحزمة الجلدية. وعند ربط الضمادات فوق الجروح يجب التأكد من عدم الإفراط في شدها لان ذلك سيؤدي إلى حبس الدورة الدموية عن العضو المصاب من الجسم.

ماذا أفعل لوقف النزف؟

تأكد من أن كل منكما (المسعف والمصاب) في وضع آمن ومن أن المجري التنفسي للمصاب مفتوحا ورئتاه تعملان بشكل طبيعي وان قلبه أيضا يعمل بشكل طبيعي، وتذكر دائما بأنه لا يوجد ما هو أهم من ذلك.

إذا كانت لديك قفازات لاتكس (بلاستيكية) ضعها على يديك فهي تقيك خطر العدوى بباكتيريا والفيروسات التي تتواجد أحيانا في دم المصاب.

ضع المصاب في وضع استلقاء على الأرض للحيلولة دون فقدانه للوعي.

حاول إيجاد مادة ماصة وغير قابلة للالتصاق بالجروح لتضميد الجرح النازف للمصاب.

اجعل الجزء المصاب أعلى من مستوى الجسم إذا كان ذلك ممكنا.

ضع قطعة سميكة من القماش فوق الضمادة على الجرح واضغط بثبات على منطقة الجرح إلى حين توقف النزف، و يستغرق وقف النزف عادة أقل من خمس دقائق.

إذا أصبحت الضمادة مشبعة بالدم تأكد من انك تجعل الضغط مباشرة على الجرح النازف.

أضف المزيد من القماش فوق القماش الذي كنت قد وضعته أصلا واضغط على الجرح بقوة أكبر.

بعد توقف النزف اربط الضمادة على الجرح بواسطة عصابة الربط.

إذا كان المصاب قد نزف لفترة طويلة فيجب استدعاء سيارة الإسعاف، سيقوم طاقم الإسعاف

بإعطاء الأوكسجين للمصاب كما أن لدى هذا الطاقم أساليب أخرى لوقف النزف إذا فشلت محاولات وقف النزف بالضغط المباشر



الجروح التي تصيب البطن:

تغطية الجرح-عدم محاولة إعادة الأمعاء أو الأجهزة الأخرى التي برزت من الجسم-تمديد المصاب على النحو الذي يشعره بالراحة ووضع غطاء تحت ركبتيه المثنيتين لتخفيف الضغط الذي يتحمله البطن-عدم إعطائه مشروب حتى لو شعر بظمأ شديد (كي لايسبب الإقياء)-اتخاذ الإحتياطات المناسبة لوقاية المصاب من المضاعفات ريثما ينم نقله إلى أقرب مركز صحي.

كيفية وقف الرعاف(النزف من الأنف):

١-أجلس المصاب بحيث يكون رأسه إلى الأمام.

٢-اضغط على الأنف من الخارج باستعمال قطعة قماش نظيفة.

٣- استمر في الضغط لمدة٣-٥دقائق.

٤-يجب نقل المصاب بالرعاف إلى المشفى في إحدى الحالتين التاليتين:

-إذا لم يتوقف الرعاف(النزف من الأنف).

-إذا كان المصاب بالرعاف يعاني من ارتفاع في ضغط الدم



كيفية وقف النزف من الأذن

إذا كان النزف من الأذن نتيجة لحادث تعرض له المصاب فان هذا النوع من النزف يعتبر غاية في الخطورة لان النزف في هذه الحالة يكون ناجما عن كسر في الجمجمة. فلا تحاول وقف النزف من الأذن، واستدع سيارة الإسعاف فورا.

ما هي الجروح القطعية التي ينبغي نقل المصاب بها إلى المستشفى؟

يجب الحصول على المشورة الطبية في الحالات التالية:

١-إذا لم يتوقف النزف من الجرح.

٢-إذا كان الجرح أطول من بوصة واحده.

٣-إذا كان الجرح أعمق من ٢ سم.

٤-إذا كان الجرح متشعبا أو منفرجا.

٥-إذا كان الجرح متسخا أو بداخله جسم غريب.

٦-إذا لم يكن المصاب قد أخذ طعم أو لقاح مرض التيتانوس خلال السنوات الخمس الماضية.

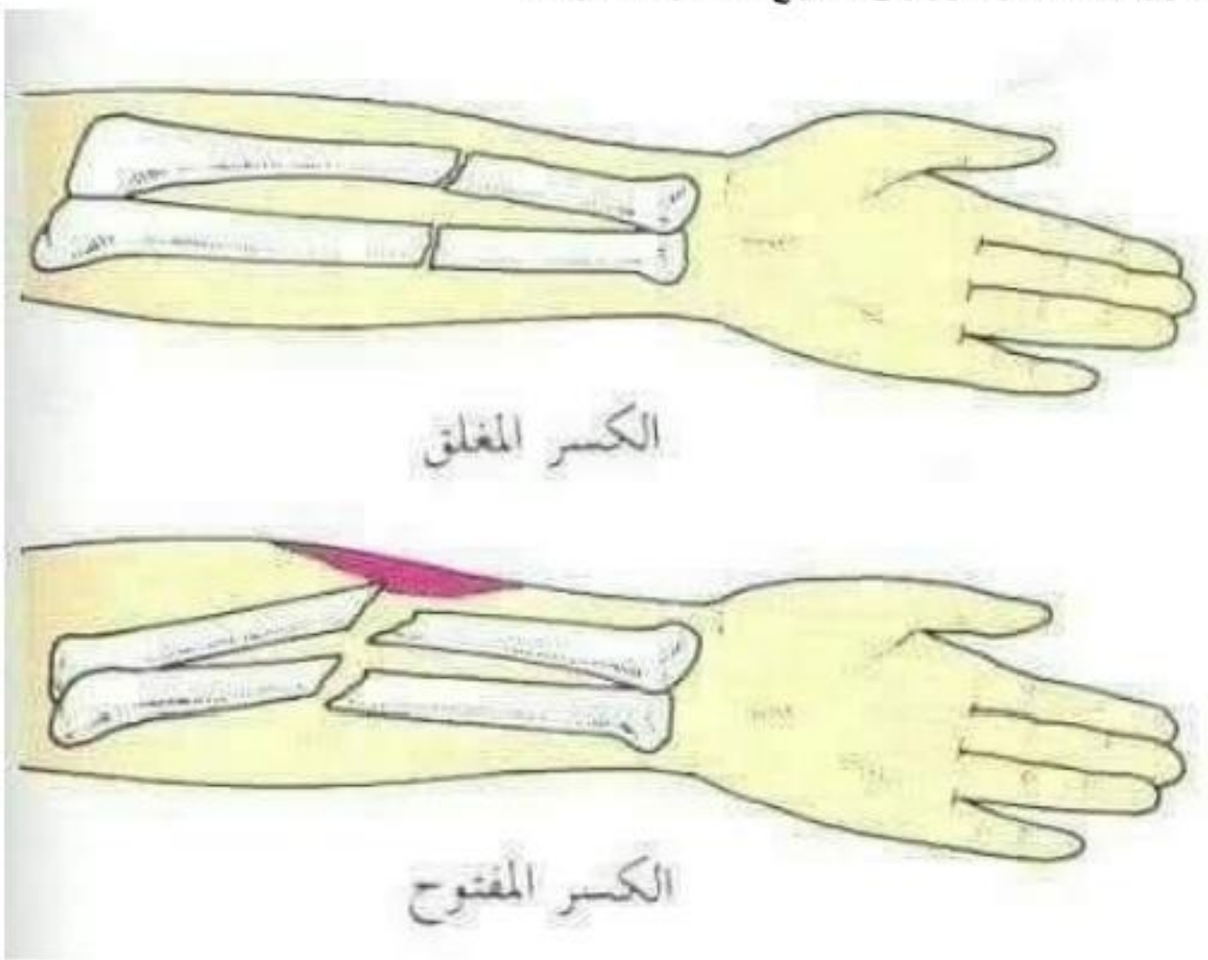
٧-إذا رأيت أن هناك ضرورة لاستشارة طبيب مختص.

إذا لم تنطبق أي من الحالات الأنفية الذكر يمكن للمسعف المباشرة في غسل الجرح بالماء والصابون زمن ثم تضميد وربط الجرح . يجب إبقاء الضمادة على الجرح إلى أن يلتئم الجرح تماما حيث أن الضمادة تساعد على بقاء الجرح رطبا الأمر الذي يعجل في شفائه.

إسعاف الكسور

الكسور المضاعفة المفتوحة:

ويكون فيها الكسر بارز إلى الخارج مصحوب بالنزف.



الكسور البسيطة أو المغلقة:

يكون فيها الكسر مغلق مع وجود ورم في مكان الإصابة مع وجود آلام شديدة.

ما هو التجبير؟

التجبير هو وضع دعامة ساندة لذراع أو ساق المصاب الذي يخشى أن تكون ذراعه أو ساقه قد تعرضت للكسر.

والهدف من التجبير هو:

وقف الألم في الطرف المصاب.

سند النهايات العظمية لمنطقة الكسر. تكون النهايات العظمية في منطقة الكسر حادة جدا، وتحول عملية التجبير دون اختراق هذه النهايات العظمية الحادة للجلد و دون تمزق العضلات والأنسجة المحيطة بها كما أن التجبير يقلل من النزف في الطرف المصاب.

تسهيل عملية نقل المصاب بأمان وراحة.

ما هي الجبيرة؟

في الحالات الطارئة يمكن استخدام إي شيء كجبيرة، وهناك نوعان من الجبائر: (جبيرة صلبه - جبيرة مرنه)

الجبيرة الصلبه: أي جسم صلب، كأن يكون قطعة من الخشب أو البلاستيك، عصا مكنسه، كتاب، رزمة جرائد، ويمكن استخدام هذه المواد كجبائر للذراع أو الساق المكسوره.
الجبيرة المرنه: أي جسم مرن القوام، كأن يكون وسادة.أو غطاء سرير مطوي عدة طيات. وتصلح هذه المواد كجبائر لكسور القدم والكاحل والمفاصل.

ما هو الوشاح الطبي والرباط؟

الوشاح الطبي عبارة عن قطعة من القماش تستخدم لتثبيت ذراع مكسورة إلى جسم المصاب، ويكون التثبيت عادة في وضع الكوع المثني. ويكون الوشاح في العادة على شكل مثلث كبير الحجم، ويمكن استخدام هذا الوشاح بالإضافة الى جبيرة صلبة كما يمكن استخدامها بدلا عن الجبيرة. إذا استخدم الوشاح منفردا بدون جبيرة فيجب تعزيزه بقطعة إضافية تسمى الرباط، والرباط نفسه عبارة عن وشاح تعليق يتم طيه بحيث يكون عرضه ٥ أو ٦ بوصات.

المبادىء العامة للتجبير:

هناك الكثير من الأساليب المتبعة في التجبير وقد تبدو هذه الأساليب للوهلة الأولى بالغة التعقيد إلا أنها في واقع الأمر سهلة للغاية.

فيما يلي عرض للمبادىء العامة التي يجب مراعاتها عند القيام بتجبير الإطراف:

١-اكشف عن منطقة الإصابة

٢-أوقف النزف باستخدام الضمادات، ولكن حاذر أن تضغط على الجزء المؤلم الذي تعرض للإصابة وظهرت عليه علامات التشوه

٣-في حالات كسور العظام التي تكون النهايات العظمية فيها قد اخترقت الجلد وبرزت للخارج يجب عدم دفع هذه النهايات إلى مكانها لأن ذلك يسبب الالتهاب كما يسبب نزفا حادا.

٤-يجب إبقاء العظم المكسور (بما في ذلك المفصل الواقع فوق منطقة الكسر والمفصل الواقع تحت منطقة الكسر) ساكنا دون حركة وذلك على النحو التالي:

إذا كان الكسر في الجزء السفلي من الذراع فيجب إبقاء كل من مفصل الكوع ومفصل الرسغ ساكنين.

إذا كان الكسر في الجزء العلوي من الذراع فيجب إبقاء كل من مفصل الكوع ومفصل الكتف ساكنين.

إذا كان الكسر في الجزء السفلي من الساق فيجب إبقاء كل من مفصل الركبة ومفصل الكاحل ساكنين.

إذا كان الكسر في الجزء العلوي من الساق فيجب إبقاء كل من مفصل الركبة ومفصل الورك ساكنين.

٥-يجب ربط الجبيرة بشكل محكم لمنع حركة الطرف المكسور مع مراعاة عدم شد الجبيرة على الطرف أكثر من اللازم حيث أن ذلك يؤدي إلى حبس الدورة الدموية عن الطرف المكسور يعمل التجبير الصحيح على تخفيف الألم الذي يعاني منه المصاب.

٦-إذا كان الطرف المكسور منثيا وكانت النهايات العظمية فيه بارزة فلا تحاول تحريكها. قم بتجبير الطرف في الوضع الذي وجدته عليه بحيث يكون هذا الوضع مريحا للمصاب قدر المستطاع.
٧-إذا تم استدعاء سيارة الإسعاف وكانت سيارة الإسعاف في طريقها إليك فلا تقم بتجبير الطرف المكسور وانتظر طاقم الإسعاف حيث أن لدى هذا الطاقم جبائر طبية ومتخصصه.
لماذا يجب علي التأكد من إبقاء المفاصل الواقعة فوق وتحت منطقة الكسر ساكنة دون حراك؟
إن نهاية كل عظمة من عظام الاطراف مرتبطة بمفصل، وحركة المفصل يترتب عليها حركة العظم المكسور لذا يجب ان تبقى المفاصل ساكنة لتظل العظام المكسورة أيضا ساكنة.
ماذا لو كان الكسر فى المفصل نفسه؟
هذا النوع من الكسور أصعب من الكسور في العظام الأخرى، ولكن يمكن تطبيق نفس الطريقة الخاصة بالتجبير. يجب التأكد من بقاء المفصل والعظام الواقعة فوق وتحت منطقة الكسر جميعها ثابتة. تخيل مفصل الكوع مثلا، انه يجمع عظم الذراع مع عظم الساعد وفي حالة الكسر يجب تثبيت المفاصل والعظام المرتبطة بها والحيلولة دون حركتها، لذا يجب إبقاء الرسغ والكتف في هذه الحالة ساكنين.
غالبا ما تحدث الإصابة للمفصل في وضع يكون المفصل فيه مؤلما جدا. في هذه الحالة لا تحاول تسوية وضع المفصل حيث أن هناك أعصاب هامة وأوعية دموية تتواجد حول المفصل وأية محاولة لتسوية أو تصحيح وضع المفصل قد ينجم عنه إتلاف للأعصاب والأوعية الدموية علاوة من أن تصحيح المفصل ينجم عنه ألم شديد.
عليك أن تكون ذا خيال واسع في تعاملك مع مثل هذه الإصابة، ويمكن تجبير المفصل في الوضع الذي يكون عليه.



ماهي المواد التي أحتاجها للتجبير؟

ستكون بحاجة إلى:

-جبيرة(صلبةأو مرنة)

-ضِمادَة سَمِيكَة تُوضَع تَحت الجبيرة لِتوفّر أكبر قدر ممكن من الراحة للمصاب. (اختياريه)

حبل أو شيء مشابه لربط الجبيرة بالطرف المكسور.

ماذا لو لم تتوفر المواد اللازمة للتجبير؟

لا داعي للقلق. يمكن استخدام جسم المصاب نفسه كجبيرة وذلك على النحو التالي:

.يمكن ربط الذراع المكسورة بواسطة عصابة إلى جسم المصاب .

.يمكن ربط الساق المكسورة بواسطة عصابة إلى الساق الأخرى للمصاب .

.يمكن ربط الإصبع المكسورة بواسطة عصابة إلى بقية أصابع المصاب .

اصابات العمود الفقري:

غالباً تنتج من حوادث السيارات او السقوط من علو واي خطا في التعامل مع ضحايا هذه الحوادث قد يعني ان يمضي الضحيه بقية عمره عاجزا ومقعدا لذا يجب مراعاة عدم تحريك اي مصاب يحتمل ان يكون لديه اصابه في العمود الفقري الابو اسطة فريق متخصص ومدرب لمثل هذه الحالات فكن حذرا

كيف تعرف ان المصاب لديه اصابه في العمود الفقري

اطرح عليه هذه الاسئله: هل تحس بالام في ظهرك

هل يمكن تحس بقدَميك هل يمكن تحريك اصابع القدمين

اذا لم يستطع ذلك بالصوره الطبيعيه فتوقع حدوث اصابه فكن حذرا

خطوات إسعاف إصابات الظهر

إن إصابة الظهر أو العنق تعد إصابة بالغة الخطورة، وإذا تم نقل المصاب من موقع الحادث .بطريقة خاطئة فيمكن أن يصاب بالشلل الدائم. لا تنقل المصاب من مكان الحادث

تأكد من سلامتك الشخصية وسلامة المصاب ومن ثم تحقق من أساسيات الإسعاف الأولى .واستدع سيارة الإسعاف

إن لدى أطقم الإسعاف جبائر خاصة بالظهر والعنق كما أنهم على دراية بالطرق المثلى للتعامل .مع مختلف الإصابات

إسعاف الطفل بعد تعرضه لضربة على الرأس:

لا تقم بتحريك الطفل الذي يشتبه بإصابته بأذية في الرأس او العنق او العمود الفقري لان اي حركة للطفل هنا قد تؤذيه وتسبب أذية خطيرة ويجب عليك فقط طلب الطبيب او الاسعاف خاصة اذا كان لدى الطفل اي مما يلي

فقد وعي اوميل شديد للنوم -صداع مستمر او اقياءات - عدم القدرة على تحريك احد الأطراف سيلان الدم او سيلان سائل اصفر من الانف او من الاذن عند وجود الاختلاجات

عند وجود اضطراب في الوعي او السلوك او الكلام

إصابات الرأس والعمود الفقري



<u>إصابات الرأس يمكن أن تكون:</u>

جروح في فروة الرأس
إصابات بالمخ
كسور بعظام الجمجمة

<u>أسباب إصابات الرأس والعمود الفقري</u>

حوادث السيارات -الوقوع من ارتفاع -الرياضة مثل الغطس

<u>الإسعافات الأولية لإصابات الرأس:</u>

لا تحرك المصاب.
ثبت الرأس والرقبة في موضع الإصابة.
أوقف النزيف وحاول السيطرة عليه.
قم بتأمين مجرى الممرات الهوائية بحيث تكون مفتوحة.
أعط الأكسجين إن وجد
لاحظ العلامات الحيوية ، مدى فقد الوعي ومدته ، التشنجات
قم بتدفئة

تعتبر كسور العمود الفقري من الكسور الخطيرة إذ قد ينتج عنها إصابة النخاع الشوكي *** .والتي قد تؤدي إلى حدوث شلل مستديم

<u>في حالة كسر العنق والعمود الفقري يجب:</u>

تركيب "ياقة طبية"قبل نقله .وينقل بعناية على لوح خشبي بأكثر من فرد ككتلة واحدة.



كيفية تثبيت حركة الرأس والرقبة:

-ضع يدك على جانبي رأس المصاب في الوضع الطبيعي.
-نقل المصاب يقوم به أربعة مسعفين على الأقل.
-إذا توفرت رقبة بلاستك يكوك هذا أفيد

الدوخة

هي شعور بدوران كل ما يحيط بك، وقد يحس المصاب بأن الغرفة تلف به أو بأن الدوران موجود داخل رأسه أو جسده.

وعادة ما تترافق الدوخة مع مشاكل في الأذن الداخلية التي تملك جهازاً فائق الحساسية تجاه الحركة. وعند إصابتها بآفة جرثومية أو رضخ أو اضطرابات أخرى، يرسل الجهاز رسالة خاطئة إلى الدماغ.

فقدان التوازن

فهو الشعور بأن عليك لمس شيء أو التمسك به لتحافظ على توازنك.

ومن شأن الفقدان الحاد للتوازن أن يجعل من الصعب تلافي السقوط.

الإغماء (Fainting)

عبارة عن مصطلح يشير إلى الفقدان المفاجئ والمؤقت لوعي الإنسان، وعادة ما يكون نتيجة انخفاض مستوى الأكسجين الواصل إلى الدماغ.

للأكسجين أهمية كبيرة في جسم الإنسان، وعدم وصوله إلى المناطق المختلفة من شأنه أن يسبب الضرر ، تماماً مثلما يحدث في حالة الإغماء.

المقصود هنا، عندما يقل تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ بشكل حاد، يقوم الدماغ بوقف عمل

جميع أجزاء الجسم غير الحيوية، لتتركز الطاقة الشحيحة المتبقية في عمل الأعضاء الأساسية في الجسم.
فعندما يلاحظ الدماغ أن مستوى الأكسجين قد قل، يحدث في الجسم الأمور التالية:
تبدأ بالتنفس بسرعة، في محاولة لتعويض هذا النقص
يرتفع معدل نبضات القلب في محاولة لإيصال الأكسجين إلى الدماغ
نتيجة لذلك ينخفض ضغط الدم لدى المصاب في الأعضاء الأخرى من الجسم
يحصل الدماغ على كمية فائضة من الدم المحمل بالأكسجين على حساب الأعضاء الأخرى
التنفس الزائد المترافق مع انخفاض ضغط الدم، يؤديان إلى فقدان الوعي المؤقت وضعف عضلات الجسم.

أسباب الإصابة بالإغماء

كما أسلفنا فإن السبب الرئيسي للإصابة بالإغماء ناتج عن نقص وصول الأكسجين إلى دماغ الإنسان.
هذا الأمر يسببه عدة أمور، أهمها:
مشاكل في الرئتين
مشاكل في الدورة الدموية لدى المصاب
التسمم بأول أكسيد الكربون
أسباب أخرى:
أولاً: أسباب متنوعة إضافية تسبب حدوث الإغماء
تتنوع الأسباب التي قد تؤدي لإصابة الشخص بالإغماء لتشمل:
مؤثرات وصدمات نفسية/عاطفية: رؤية مشاهد صدمية (مثل الدماء)، التواجد في تجارب غير محببة، الصدمات الانفعالية الناتجة عن الأخبار السيئة، أو التوتر الشديد والإحراج.
عوامل ميكانيكية ووظيفية: الوقوف الطويل بدون حركة، أو الانتقال السريع والمفاجئ من وضعية الجلوس إلى الوقوف.
عوامل بيئية وبدنية: التواجد في أماكن مزدحمة وحارة لفترات طويلة، أو الإجهاد البدني الشديد
حالات مرضية واستقلابية: الجفاف، اضطراب مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، بعض أمراض القلب، أو الإفراط في تناول الكحول خلال فترة زمنية قصيرة.
ثانياً: أعراض ومراحل ما قبل حدوث الإغماء
يمر المصاب قبل فقدان الوعي بعدة علامات وأعراض متدرجة:
*الشعور بثقل القدمين والارتعاش
ينخفض ضغط الدم ومستوى الكالسيوم فيه، مما يسبب وخزاً في الأطراف والأعصاب ورعشة خفيفة.
التصرف الإسعافي: فتح مجرى الهواء للمصاب وإزالة أي عائق يمنع التنفس السليم، لتسهيل ضخ الدم للأطراف.
*اللهث والتنفس السريع :يحاول المصاب التقاط الأنفاس بصعوبة قبل السقوط.
التصرف الإسعافي: الجلوس فوراً والاستلقاء مع وضع اليد على البطن والتنفس ببطء

*توهج وغباش الرؤية:
تقل حدة الرؤية وتنغلق حدقة العين تدريجياً:
التصرف الإسعافي: جلوس المصاب وضع رأسه بين ركبتيه للمساعدة في إعادة تدفق الدم إلى الدماغ
*الارتباك والشعور بالحر
*الدوار والدوخة الشديدة
ينجم عن الهبوط المفاجئ في ضغط الدم
التصرف الإسعافي: شد أو الضغط على عضلات الجزء السفلي (الفخذين أو الساقين) عند استشعار الدوار.
أعراض أخرى مترافقة:
*الغثيان والرغبة في القيء و*التعرق الزائد والتثاؤب المستمر
شحوب البشرة: يتحول لون الوجه إلى الأصفر نتيجة الشحوب؛ ويجب حينها تأمين هواء نقي وجعل المصاب يجلس بوضعية صحيحة
ثالثاً: تصنيف أنواع الإغماء
إغماء موضعي: وينتج بالأساس عن تراجع وانخفاض تدفق الدم وضغطه في المخ
إغماء مرضي:
يكون سببه أمراض في القلب والأوعية الدموية، أو مشاكل في الجهاز العصبي والمخ.
الإغماء المفاجئ
يحدث الإغماء مباشرة بعد انخفاض ضغط الدم المفاجئ، إنما تظهر بعض العلامات أولاً قبل أن يسقط الشخص أرضاً، لذا عليك معرفة هذه العلامات لتأخذ احتياطك لتجنب الإصابة:
الإسعافات الأولية لحالات الإغماء
التأكد من بقاء مسلك الهواء مفتوحاً لدى المصاب بحالات الإغماء
أن يتنفس المصاب بشكل جيد، ويجب مراقبة النفس في منطقة الصدر والبطن
فك الملابس الضيقة أو ربطة العنق، أو أي شيء يعيق عملية التنفس لدى المصاب
فحص المصاب سريعاً والتفتيش عن أي إصابات خطيرة في جسمه نتيجة السقوط
المصاب في وضع الإفاقة وهو كالآتي:
وضع الإفاقةهو الوضع الذي يبقي مسلك الهواء لدي المصاب مفتوحاً، بحيث لا يسقط اللسان في الحلق، كما يبقي الرأس والعنق مسطحين فيتسع ممر الهواء.
ومن الضروري أن تكون أطراف المصاب في وضع الاستقرار للحفاظ على ثبات الجسم، ويظل في وضعية آمنة ومريحة.
في حال شعورك بالإغماء
والمقصود هنا ظهور الاعراض ما قبل الإغماء، في هذه الحالة من المهم القيام بما يلي
اعثر على مكان لتجلس فيه
عند جلوسك يجب وضع الرأس بين ركبتيك .
عندما تشعر بتحسن، ارفع رأسك رويداً رويداً.

Shock الصدمة

الصدمة هي الاضطراب الناجم عن نقص تروية أنسجة الجسم المختلفة بالدم الحامل للأكسجين والغذاء مما يؤثر على الوظيفية الخلوية الفيسيولوجية ويتسبب بالموت الخلوي يتبعه الفشل العضوي والفشل الجهازي بأكمله والوفاة.

تعد الصدمة حالة طبية طارئة تهدد حياة المصاب مما يتطلب التدخل العلاجي الفوري.

تصنف الصدمة اعتماداً على عاملها المسبب الى:

a-صدمة قلبية المنشأ

b-صدمة نقص حجم الدم

c-صدمة الانتانية

d-صدمة عصبية

ترتبط الاصابة بالصدمة بالاضطرابات المرضية التي تؤثر في التدفق الطبيعي للدم ومنه:

أمراض القلب (فشل القلب، النوبة القلبية

انخفاض حجم الدم المرتبط بالنزيف الحاد او الجفاف

اضطرابات الأوعية الدموية المرتبطة بتفاعلات التحسس المزمنة أو العدوى

العقاقير الدوائية التي تقلل من الوظيفة الفيسيولوجية للقلب أو تخفض ضغط الدم

اصابة النخاع الشوكي.

يتم التمييز، عادةً، بين ثلاث مراحل مختلفة في حالة الصدمة، تختلف بدرجة حدتها ومدى خطورتها:

-مرحلة ما قبل الصدمة :فقدان حتى ١٠٪ من حجم الدم، مصحوباً بنبض سريع وانخفاض طفيف في ضغط الدم. في هذه المرحلة تكون الأجهزة الدفاعية في الجسم لا تزال قادرة على التعويض عن خسارة الحجم هذه.

- مرحلة الصدمة :فقدان أكثر من ٢٠٪ من حجم الدم، أو انخفاض ملحوظ في النتاج القلبي مصحوباً بانهيار قدرة الأجهزة الدفاعية على التعويض ومن ثم ظهور (Cardiac output) أعراض الصدمة.

-الصدمة غير القابلة للإصلاح: استمرار حالة الصدمة من دون علاج يسبب ضررا شديدا غير (Irreversible) قابل للعكس في الخلايا والأنسجة ,فشلا مجموعيا وموت المريض.

العلامات والأعراض المرافقة للصدمة:

١-زراق الشفتين وأطراف الأصابع .

٢-ألم الصدر.

٣-الدوار أو الاغماء .

٤-الارتباك والتشويش.

٥-رطوبة،برودة وشحوب الجلد.

٦- فرط التعرق.



٧-انخفاض أو انعدام الناتج البولي.
٨-نبض القلب السريع والضعيف .
٩-التنفس العميق.
١٠-فقدان الوعي.

يشمل إسعاف الاصابة بالصدمة عدد من الاجراءات الاسعافية ومنها:

١-تقييم وعي المُصاب الكافي وقدرته على التنفس بشكل مُستقل أو انسداد الانف او الفم وتعذر التنفس. تقييم عملية تنفس المُصاب وفيما اذا كان بحاجة الى التنفس الاصطناعي

٢-تقييم ضغط الدم الكافي وفيما اذا كان المُصاب بحاجة الى السوائل الوريدية أو العقاقير الدوائية لتعزيز ضغط الدم

٣-السيطرة على النزيف الدموي بالضغط المباشر على موقع النزيف ونقل وحدات الدم في حال فقدان كميات كبيرة منه

٤-التحقق من تركيز الغلوكوز في الدم عن طريق وخز الاصبع للكشف عن عدم انخفاض غلوكوز الدم الحاد.



علاج الصدمة

معالجة حالات الصدمة يجب أن تتم بشكل فوري ودون أي تأخير، من أجل منع تفاقم الحالة وأضرارها. الهدف من العلاج هو تحسين تدفق الدم وتزويد الأنسجة بالأكسجين. ويختلف العلاج باختلاف العامل المسبب الذي أدى إلى حصول الصدمة، ويشمل: معالجة المسبب الأولي الأساسي الذي أدى إلى حصول الصدمة، تحسين تزويد الأنسجة بالأكسجين ومعالجة فشل أجهزة الجسم الناشئ عن الصدمة.

*في حالة صدمة نقص حجم الدم: يجب الحرص على عدم بذل جهد جسماني قوي، من أجل سوائل إلى داخل –(Instillation إدخال العلاج قطرة قطرة) التقليل من فقدان السوائل وتستيل الوريد، تبعا لمستوى ضغط الدم والنبض. يجب العمل على وقف النزيف النشط بواسطة الضغط ، (Arterial tourniquet) الموضعي على مكان الإصابة أو وضع عاصبة شريانية إجراء عملية جراحية لوقف نزيف داخلي و تسريب كريات دم حمراء، في حالة فقدان كمية كبيرة من الدم.

*في حالة الصدمة القلبية المنشأ: الخلود إلى الراحة، الحصول على الأكسجين، معالجة الاضطراب في نظم القلب، تناول أدوية موسعة للأوعية الدموية في عضلة القلب والتي تقلل من الضغط على القلب. تزويد الجسم بماده مذيبة للدم المتخثر الذي سبب الاحتشاء وفتح الأوعية الدمزية عن طريق إدخال قثطار( )أحيانا يستوجب الأمر إجراء عملية جراحية يتم فيها وضع المجازات في الأوعية الدموية المسدودة أو لإصلاح خلل/عيب في الصمام.

*في حالة الصدمة الناتجة عن توسع الأوعية الدموية: يجب تزويد الجسم بالسائل بواسطة التستيل، بسرعة ودون أي تأخير. أعطاء أدوية لتقليص الأوعية الدموية، وإعطاء مصل خاص مضاد لسم اللدغة.

في حالة صدمة التأق: السوائل، الستيرويات والأدرينالين.*

*عندما يكون المسبب للصدمة تلوثا جرثوميا متفشيا، يجب إزالة مصدر التلوث - إعطاء المضاد الحيوي الملائم، إعطاء المريض السوائل والأدوية المقلصة للأوعية الدموية. إذا ظهر المتفاعل C التهاب صعب، فيجب إعطاء المريض ستيرويات بجرعة ضئيلة والبروتين (Proteina C reactiva)



التشنجات

تعريف التشنج:

شلل أو توتر في جميع عضلات الجسم أو جزء منها. وأحيانا تكون مصاحبة لفقدان الوعى أو يكون المصاب واعياً.

أسباب التشنج:

الأطفال تحت سن ٥ سنوات نتيجة ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

المرأة الحامل.

مرض الصرع.

اصابات الرأس المصحوبة بنزيف.

علامات وأعراض التشنج:

يسقط المريض مغشيًا عليه وتتصلب العضلات ، وذلك عدة ثوان إلى نصف دقيقة يحدث بعدها ارتعاش بنفس العضلات.

أثناء فترة التصلب قد يتوقف التنفس ويخرج اللعاب من الفم وقد يفقد السيطرة على البول والبراز.

الإسعافات الأولية:

قم بحماية المصاب من إيذاء نفسه.

ضعه على الأرض مستلقياً على ظهره.

فك الملابس حول الرقبة.

انتظر عدة دقائق حتى تنتهى التشنجات.

اذا تقيأ المصاب ، أدر رأسه لأحد الجانبين.

أثناء التشنجات:

لا تحاول أن توقف التشنجات.

لا تعطى أى شيء بالفم.

اذا كان المصاب نائماً بعد انتهاء التشنجات ، وانتظر بجانبه حتى يفيق تماماً

تشنجات المرأة الحامل:

في حالة تشنجات المرأة الحامل تكون حياة الأم والطفل في خطر.

-أعط الإسعافات الأولية حسب الحاجة.

-انقل الحامل إلى أقرب مركز طبي فورا.

-أخبر الطبيب أن السيدة الحامل قد أصيبت بتشنجات.

الإسهال



تعريف الإسهال:

يحدث الإسهال عندما يتبرز الشخص ٣ مرات أو أكثر في اليوم ويكون البراز سائلا.

علامات دالة على خطورة الاسهال:

_إسهال مستمر لأكثر من يومين.

-إسهال مائي.

-قيء مستمر.

-عطش مستمر.

-حرارة عالية.

-دم في البراز.

الإسعافات الأولية:

أعط الشخص المصاب كميات كبيرة من السوائل عن طريق الفم،إذا كان الطفل رضيعا فإعطه كميات أكبر من لبن الأم.

أمثلة السوائل:شوربة-ماء الأرز-محلول معالجة الجفاف.

كيفية إعطاء محلول الجفاف:

-يعطى معلقة من المحلول كل دقيقة

-إذا كان عمر المريض أكثر من سنتين يتم إعطاؤه رشفات متكررة من المحلول.

-إذا كان المريض يتقيأ فانتظر ١٠ دقائق ثم اعط ببطء أكثر أى كل ٣ - ٤ دقائق.

ملاحظة هامة:

يتم تحضير محلول معالجة الجفاف يوميًا ولا يحفظ لمدة أكثر من ٢٤ ساعة.

التعرض للحرارة الشديدة

ينتج عن التعرض للحرارة الشديدة ثلاث إصابات مختلف

الصدمة الحرارية (ضربة الشمس)

الإنهاك الحرارى (الإجهاد)

التقلصات العضلية

الصدمة الحرارية(ضربة الشمس)

تحدث نتيجة التعرض للشمس أو حتى فى الظل مما يؤدى إلى فشل ميكانيكية تنظيم درجة حرارة الجسم

الأعراض:

ارتفاع حاد فى درجة حرارة الجسم

الجلد ساخن وجاف

إنخفاض فى درجة الوعى

تشنجات أو إلتواء العضلات

الإسعافات الأولية :

تأكد أن المصاب يتنفس ولديه نبض.

ابدأ بإنعاش القلب والتنفس فورًا إذا لزم الأمر.

أبعد المصاب عن الجو الساخن.

ضع فوطا مبللة على جسم المصاب.

ضع المصاب فى تيار هوائى بارد.

ضع كمادات ماء بارد.

أطلب الإسعاف فورًا.

الإنهاك الحرارى

ينتج عن نشاط جسمانى فى درجة حرارة عالية تؤدى إلى عرق غزير دون تعويض الجسم.

الأعراض

حرارة الجسم تكون طبيعية أو مرتفعة قليلاً.

الجلد رطب بارد شاحب اللون.

دوخة ، صداع ، غثيان ، قيء ، تقلصات بالعضلات.

الإسعافات الأولية:

يعالج المصاب كأنه فى صدمة.

إعطاء المصاب محلول معالجة الجفاف أو ماء بارد.

التقلصات العضلية

تحدث نوبات متقطعة من التقلصات العضلية عادة بعد انتهاء التمارين الرياضية أو بعد العمل

انقل المصاب إلى منطقة باردة.

افرد أو مد العضلة برفق.

لا تقم بتدليك العضلة

اعط المصاب ماء بارد أو محلول معالجة جفاف أو محلول ملح.

إذا لم يحدث تحسن ، عامل المصاب كأنه مصاب بإنهاك حرارى.

التسمم بالمواد الكيماوية

الإسعافات الأولية في حالات التسمم بالمواد الكيماوية والمنظفات المنزلية

التسمم :هو دخول أي مادة ضارة (طبيعية أو مصنعة) أو ملوثة إلى الجسم بكمية معينة فتحدث أضراراً داخل الجسم.

المنافذ التي تدخل منها المواد السامة إلى الجسم:

البلع: عن طريق الفم والجهاز الهضمي.

الاستنشاق: أي عن طريق الجهاز التنفسي (مثل الغازات و الأبخرة السامة و أدوية التخدير الغازية.

الحقن: مثل لسع الحشرات أو حقن الأدوية بالجلد أو تحت الجلد أو الحقن العضلي أو الوريدي.

الجلد: عن طريق الامتصاص (مثل الدهانات و المواد الكيميائية)

يمكن تقسيم التسمم من حيث المسبب إلى:

تسمم بالأدوية.

تسمم كيميائي.

تسمم غذائي.

أعراض وعلامات التسمم:

يبنى التشخيص على أمور عديدة هي ظروف الحادث والمشاهدات المسجلة في مكان وقوعه ثم العلامات المرضية التي ظهرت على المصاب بالإضافة إلى نتائج التحاليل

(أ) ظروف الحادث وفحص المكان:

إن أكثر الأمور إثارة للشبهة بالتسمم هو حدوث أعراض مرضية حادة متشابهة عند أشخاص تناولوا طعاماً أو شراباً واحداً، وجود بعض المواد الكيماوية أو الدوائية السامة في الغرفة (يمكن ملاحظة رائحة غريبة أو مميزة أو لون سائل غريب)، أو وجود زجاجات فارغة تستعمل لحفظ هذه المواد أو وجود علبة الدواء قرب المصاب (أو تناثر أقراص الدواء بجانب المصاب).

(ب) العلامات المرضية:

١-الأعراض المعوية:

غثيان وقيء - آلام شديدة في البطن - إسهال

وللقيء رائحة خاصة مميزة مثل حالات التسمم بالسيانيد (رائحة اللوز المر) والفسفور العضوي (رائحة الثوم).

٢-الأعراض التنفسية:

وتتمثل في السعال والزرقة وضيق التنفس خاصة في حالات التسمم بالأبخرة والغازات المهيجة ،المعدل الطبيعي للتنفس في البالغين حوالي ١٦ مرة في الدقيقة.

٣-الأعراض الدماغية:

وتظهر نتيجة إصابة الجهاز العصبي المركزي وتأخذ أشكالاً متعددة:

الغيبوبة

التشنجات

الهياج (الهوس)

٤-أعراض التسمم بابتلاع المواد الأكالة كالأحماض المركزة و المنظفات
حروق على الفم و آلام شديدة بالبلعوم والصدر نتيجة لاحتراق المريء.

القواعد العامة لإسعاف حالات التسمم:

إن الهدف الأساسي من سرعة إجراء الإسعافات الأولية للمصاب بالتسمم هو تخفيف المادة السامة بأقصى سرعة ممكنة وطلب المساعدة الطبية والمحافظة على سلامة التنفس والدورة الدموية والوظائف الحيوية الأخرى لدي المصاب.

لكي يتم الإسعاف بصورة سليمة يجب مراعاة الأتي:

١-تأكد من عدم وجود خطر إضافي (عليك أو على المصاب) بسبب قيامك بإسعاف المصاب

٢-إذا كان ممكناً:

-حدد نوع السم أو الدواء أو الغذاء واحتفظ بوعائه وبقاياه أو غلافه.

-معرفة الجرعة أو المقدار المتعاطى من المادة.

-وقت التعاطي (أي كم من الوقت مضى على تناول المادة).

-عمر الشخص ووزنه.

٣-معرفة ما إذا كان التسمم عن عمد أم خطأ.

٤-ملاحظة الأعراض المصاحبة (سواء شديدة أو خفيفة).

٥-إذا وجد قيء يتم التحفظ عليه (ليسهل تحليله من الجهات المختصة).

٦-اتصل بمركز السموم أو المستشفى واحصل على النصائح الأولية .

٧-اطلب الإسعاف أو المعونة الطبية، أو انقل المصاب .

٨-وتأكد أن السم ووعائه في معية المريض إلى المستشفى.

٩-إذا كان فاقداً للوعي: يجب فحص التنفس تقديم الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر .

أهم الأسباب الشائعة لحالات التسمم:

١-السموم المنقولة من حاوياتها الأصلية إلى الزجاجات المنظفات والمطهرات المنزلية.

٢-إهمال الوالدين بترك المواد الخطرة في متناول الأطفال

٣-التخزين الغير صحيح للمواد السامة .

٤-استنشاق وابتلاع المواد السامة .

٥-عدم مراقبة الأطفال والإشراف عليهم .

٦-الرغبة في الانتحار .

تلوث الجلد أو العين بالمواد السامة

أولا: الإسعافات الأولية عند بلع المواد الكيماوية والمنظفات المنزلية

١-يراقب التنفس مع عمل تنفس صناعي إذا لزم الأمر.

٢-إعطاء لبن بارد وبياض بيضة.

٣-إعطاء مسكن قوي لتخفيف الألم.

٤-يمنع إحداث قيء للمصاب.

٥-يمنع غسيل المعدة.

٦.-يمنع إعطاء أحماض مثل الخل وعصير الليمون في حالات التسمم بالقلويات مثل الفلاش.

٧-ينقل المصاب للمستشفى فوراً.

ثانيا: **المواد المطهرة والمعقمة مثل الفينيك والديتول والفورمالين**
أن كثرة التعرض لهذه المواد سواء باللمس أو الاستنشاق قد يؤدي لحالات التسمم لذا يجب الحرص على تهوية المكان جيداً عند استخدام هذه المواد.
الإسعافات الأولية عند بلع المطهرات والمعقمات المنزلية:
١-في حالة تلوث الجلد يغسل بماء وفير ثم كحول ١٠% والأفضل بزيت الزيتون أو الخروع.
٢-في حالة شرب المواد المطهرة يفضل إعطاء شراب مقيئ (عرق الذهب) في حالة وعي المريض.
٣-ثم ينقل المصاب للمستشفى فوراً.

ثانياً: التسمم عن طريق الاستنشاق

تنتج كثير من حالات التسمم عن استنشاق بعض الغازات أو أبخرة السوائل السامة وتتميز حالات التسمم بالاستنشاق بسرعة وصول السم إلى الدم ومن ثم سرعة حدوث التسمم ... لذلك يراعى إسعاف المريض في هذه الحالة في أسرع وقت ممكن مع إتباع الإرشادات التالية:
١-ينقل المصاب فوراً من الجو المشبع بالغاز أو البخار السام إلى هواء نقي مع تحرير الجسم من الملابس الضاغطة وفك أربطة العنق.
٢-إجراء تنفس صناعي في حالة هبوط أو فشل التنفس، بعد إزالة الأشياء الموجودة بالفم وذلك على النحو التالي:
أ) إمالة الرأس المصاب الي الخلف وذلك لتفتيح المسالك الهوائية مع إغلاق فوهتي الأنف بالأصبع وأخذ شهيق عميق ووضع شفتي المعالج بإحكام فوق فم المصاب ونفخ الهواء في رئتيه، وذلك مع مراقبة صدر المريض الذي يرتفع عندما يصل الهواء الي داخل الرئتين.
ب) يرفع فم الشخص المعالج حتى يتمكن المريض من عملية الزفير مع مراقبة انخفاض الصدر
ج) تتكرر العملية السابقة حتى يستعيد المصاب تنفسه الطبيعي.
٣-تدفئة المريض إذا ظهرت عليه علامات البرد أو القشعريرة
٤-هدئ من روع المصاب بالتسمم إذا كان واعي لما حوله
٥-انقل المصاب فوراً إلى المستشفى.

ثالثاً: التسمم عن طريق الجلد

قد يتعرض الجلد للتلوث بإحدى المواد الكاوية ، التي تؤدي الى حدوث إصابات بالغه في الجلد ، ويجب أن نخلص الجلد من هذه المواد بأقصى سرعة ممكنة بإتباع التالي:
١-غسل الجلد بتيار من الماء المتدفق مع خلع ملابس المصاب والاستمرار في غسل الجلد بالماء أثناء خلع الملابس ،ثم يغسل الجلد بعد ذلك جيدا بالماء والصابون.
٢-عدم وضع أي دواء أو مادة كيميائية على الجلد المصاب وذلك لان بعض المواد الكيميائية قد تضاعف من إصابة الجلد.

رابعاً: التسمم عن طريق العين

الإسعافات الأولية المتبعة في حالات التسمم عن طريق العين:
فتح الجفنين باليدين مع غسل العين بما متدفق (يراعي ان يكون ضغط ماء الغسيل خفيف لمدة عشرة دقائق على الأقل).

٢-لا تستعمل أي نوع من القطرات
٣-انقل المصاب لأقرب مستشفى

الصابون والمنظفات الصناعية والشامبوهات

معظم الصابون المستخدم للتنظيف المنزلي غير سام نتيجة معادلة المواد القلوية المستخدمة فيه كذلك يستخدم محلول الصابون كمساعد للتقييز بديلاً لعرق الذهب في حالات التسمم إذا لم يتوفر الأخير. أما المنظفات الصناعية مثل (أومو - برسيل - تايد وغيرها) فإنها تحتوي على مواد عضوية وغير عضوية ومواد منعمة للغسيل وإنزيمات تسهل عملية التنظيف. وتعتبر هذه المنظفات أقل سمية من المنظفات الأخرى الشديدة القلوية مثل فلاش وكذلك مسلكات البالوعات إلى ١١. وقد يضاف للمنظفات مواد أخرى (PH) والتي قد يصل المعامل الهيدروجيني فيها مثل الكلوركس الذي يحتوي على ٣-٦% من هيبوكلوريت الصوديوم (bleaches) للتبييض الذي يتحول في المعدة - بعد اتحاده مع حمض الهيدروكلوريك - إلى حمض الهيبوكلوراس الذي له أثار موضوعية مهيجة للأغشية المخاطية للجهاز الهضمي، ولا يوصى بمعادلة هيبوكلوريت الصوديوم مع الأحماض أو القلويات الشديدة وذلك لأنه في هذه الحالة يتكون غاز الكلور أو غاز الكلورامين بالتبادل وهما من الغازات المهيجة للأغشية المخاطية وقد يؤديا إلى الاختناق.
أما الشامبوهات فهي قليلة السمية إلا من بعض الأثار المهيجة البسيطة للأغشية المخاطية ولكن بعض الشامبوهات تحتوي على مواد تمنع قشور الشعر مثل السيلينيوم الذي قد يؤدي إلى أعراض تسممية مع كثرة استعمال الشامبو أو ابتلاعه بطريق الخطأ.
بعض المطهرات ومزيلات العرق ومضادات البكتيريا تحتوي على مركبات الأمونيا الرباعية وهي مركبات شديدة القلوية وسامة (quaternary ammonium compounds).

إسعاف الطفل المصاب بارتفاع في درجة الحرارة

تعتبر درجة حرارة الطفل مرتفعة اذا كانت اكثر من ٣٧,٥ درجة منوية ويكون ملمس جلدالطفل عندها حارا او يكون الطفل مصابا بالقشعريرة او التعرق ويفضل دائماقياس درجة حرارة الطفل وكإجراء اولي قم باعطاء الطفل احد الادوية الخافضة للحرارة التي يصفها طبيب الأطفال عادة وافضلها تحاميل السيتامول او شرابالبروفين ولا تعط الطفل الأسبيرين خاصة في حالات الكريب وجدري الماء وضع كمادات الماء البارد او الثلج او الكحول على جسم الطفل اما اذا كانتحرارة جسم الطفل مرتفعة بسبب تعرضه لاشعة الشمس لفترة طويلة فقم بنقل الطفلالى مكان اكثر برودة واعطه الكثير من السوائل وأخيرا تذكر دوما ان الحرارليست مرضا بحد ذاتها وانما هي احد اعراض المرض ولابد من مراجعة الطبيبلمعرفة سبب الحرارة خاصة اذا كان عمر الطفل اقل من ثلاثة أشهر.

مبادئ إسعاف الحروق

ماهي أنواع الحروق:

تقسم الحروق بشكل أساسي إلى ثلاثة أنواع:

-الحروق الناجمة عن الحرارة:

وهي الحروق التي تنجم عن التعرض لشيء حار كالنار واللهب وأدوات المطبخ.

-الحروق الناجمة عن المواد الكيماوية:

وهي الحروق التي تنجم عن تعرض جلد الإنسان لمواد كيماوية أكالة.

-الحروق الكهربائية:

وهي التي تنجم عن ملامسة جسم الإنسان للتيار الكهربائي أو للصواعق.

ماهي الدرجات المختلفة للحروق:

تصنف الحروق إلى ثلاث درجات وذلك تبعا لمقدار تعرض الجلد للحرق:

-الحروق السطحية (حروق الدرجة الأولى):

تشمل هذه الحروق الطبقة الخارجية للجلد، وتتميز هذه الحروق باحمرار الجلد مع قدر كبير من الألم، ومن الأمثلة على هذا النوع من الحروق تلك الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس.

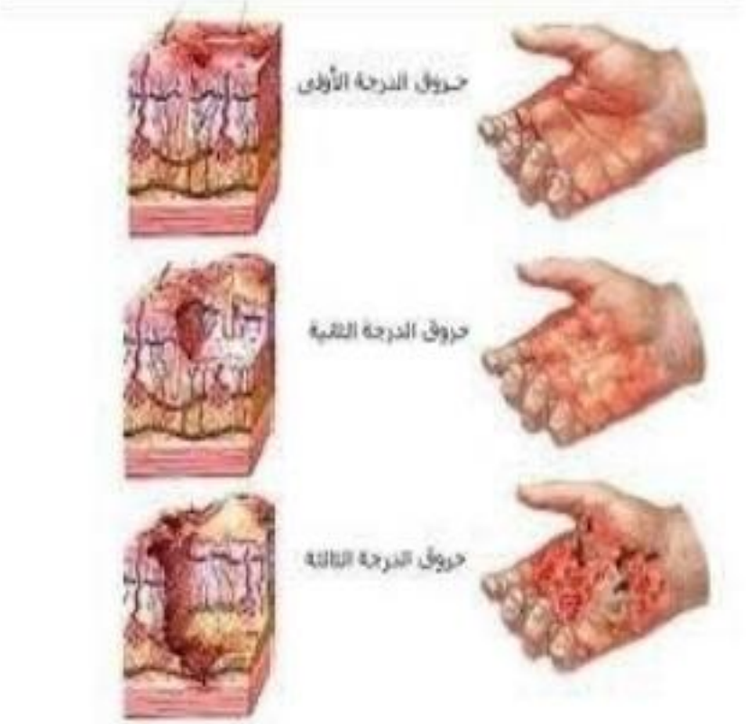


-الحروق العميقة نسبيا(حروق الدرجة الثانية):

وتشمل هذه الحروق الطبقتين الخارجية والتي يليها من طبقات الجلد، وتتميز هذه الحروق بألم شديد جدا بالإضافة إلى احمرار وتقرح في الجلد.

الحروق العميقة (حروق الدرجة الثالثة) :

وتكون جميع طبقات الجلد في هذه الحالة قد احترقت بما في ذلك الأعصاب والعضلات والأنسجة الداخلية، ويكون الجلد في هذه الحالة أسودا متفحما ولا يشعر المصاب بأي ألم في منطقة الحرق من الدرجة الثالثة لأن النهايات العصبية تكون قد احترقت. وتكون منطقة الحروق من الدرجة الثالثة في العادة محاطة بمنطقة حروق من الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى



ماذا أفعل في حالات الحروق؟

إن أول شيء يترتب عليك فعله هو التأكد من انك ستكون في مأمن من أي خطر حتى تتمكن من إنقاذ شخص مصاب. لا تغامر بحياتك من أجل إنقاذ الآخرين.

-تحقق من أساسيات الإسعاف الأولي (التنفس وعمل القلب) واستدع سيارة الإسعاف.

-حاول أن توقف عملية الحرق، وذلك من خلال:

-إخماد اللهب.

-ترطيب منطقة الحرق باستخدام الماء.

-نزع الملابس المحترقة (من غير لهب).

-برد منطقة الحرق بماء جار واغمس الطرف المصاب في الماء إذا لم يكن الجلد قد تقرح أو تشقق، وبرد الحروق لبضعة دقائق وتجنب استخدام الثلج في تبريد منطقة الحرق.

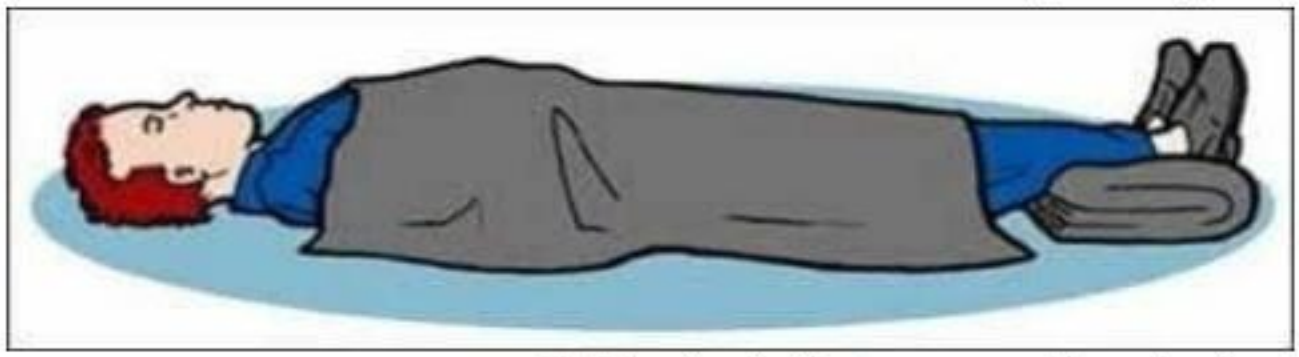
-غط منطقة الحرق بضمادة نظيفة ومعقمه.

-إذا كانت الحروق شاملة وتغطي مساحات كبيرة من الجلد لا تبرد مناطق الحروق بالماء لان ذلك قد يؤدي إلى انخفاض خطر في درجة حرارة المصاب. فقط غط جسم المصاب بقطعة قماش جافة ونظيفة ثم استدع سيارة إسعاف وذلك بعد التأكد من أساسيات الإسعاف الأولي.


١١٠
١
أبعد المصاب عن منطقة الخطر
٢
اسكب الماء البارد على منطقة الحرق لمدة ١٠ دقائق
٣
غط المنطقة المحروقة بضماد جاف
٤
مدد المصاب بوضعية الإنعاش إذا كان فاقد الوعي وراقب العلامات الحيوية لديه
٥
لاتفقع الفقاعات المائية في منطقة الحرق
٦
في الحروق الكهربائية أبعد المصاب عن التيار دون لمسه مباشرة وافصل مصدر التيار الكهربائي فوراً

الإسعافات الأولية للحروق الكبيرة

تأكد من عدم تغطية منطقة الحروق بأية مراهم أو بالزبدة او بأية مادة أخرى.
استخدم الماء والضمادات فقط لان إي شيء آخر تغطي به الحرق سيتم إزالته حتما في المستشفى، كما أن إزالة إي شيء آخر تغطي به الحرق سيؤدي إلى زيادة الم المصاب وإحداث المزيد من التلف لجلد المصاب علاوة عن أن ذلك قد يزيد من فرص حدوث التهابات لدى الشخص المصاب.



إي المصابين بالحروق يجب إرساله إلى المستشفى؟

يجب إرسال إي شخص مصاب بالحروق إلى المستشفى في حالة حدوث واحد أو كل مما يلي:
احتراق جزء كبير من جسم المصاب.
احتراق وجه المصاب.
احتراق يدي او قدمي المصاب أو مؤخرته أو أعضاؤه التناسليه.
احتراق مفاصل المصاب.
إحاطة الحرق بأحد أطراف المصاب إحاطة كاملة.
إذا كان المصاب يشعر بالدوار او بصعوبة في التنفس او كان يسعل.

ماذا علي أن أفعل في حالة الحروق الناجمة عن مواد كيماويه؟

يجب غسل منطقة الحروق الناجمة عن المواد الكيماوية بكميات كبيرة من الماء، وتعد أفضل طريقة للقيام بذلك هي وضع المصاب تحت مرشة الحمام.
تأكد من حماية نفسك من تأثير المواد الكيماوية التي تعرض لها المصاب.
تحقق من أساسيات الاسعاف الأولى.
سلط ماءا دافقا على منطقة الحروق لمدة عشرين (٢٠) دقيقه.
ضع المصاب تحت الماء الجاري اذا كان جسم المصاب قد تعرض بالكامل للحروق أو ضع الطرف الذي تعرض للحرق تحت الماء الجاري.
يجب فحص وتقييم حالات الحروق الناجمة عن المواد الكيماوية في المستشفى.

الصدمة الكهربائية:

.يحدث فقد وعي ويترافق مع شلل تنفسي وقد يحدث تليف بطيني وتوقف القلب
:أسعاف المصاب بالصدمة الكهربائية
يقطع التيار أو يبعد المصاب بمادة عازلة وليست رطبة عن مصدر التيار ثم يطبق التنفس الاصطناعي ويمسد القلب ويحرر مجرى الهواء ويستدعى الأسعاف.

إسعاف اللدغات

لدغات الحشرات

كلّ ما على هذه البسيطة من كائنات حيّة لها نظام حماية للدفاع عن نفسها ومن هذه الكائنات هي الحشرات، ولهذا فإنّ تعرّض الإنسان للسعات الحشرات أو كما تسمى اللدغات، ما هي إلا طريقة لحماية الحشرات نفسها من المخاطر، ولكلّ نوع من أنواع الحشرات طريقة مختلفة للدغ أو اللسع وتأثير مختلف على الإنسان، فمنها ما يحتاج إلى إسعافات أولية بسيطة ومنها ما يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة، وقد يكون الإنسان المعرض للدغ مصاباً بحساسية ضد المواد المفرزة من الحشرات تؤدي إلى ردّ فعل خطير،

أعراض لدغات الحشرات

لا بدّ أن تعرّض كلّ إنسان إلى لسعات الحشرات، وبغض النظر عن نوع الحشرات، سواء كانت من البعوض، النمل، النحل، الدبور أو من الحشرات الأخرى، فإن تأثيرها غالباً ما يكون طفيفاً، ويتفاعل جسم الإنسان مع المواد المفرزة من الحشرة من السموم والبروتينات التي تنتقل إلى الجسم أو تحقن من خلال لعابها، ويمكن أن يؤدي هذا التفاعل إلى **ظهور أعراض في موقع اللدغة منها:**

١-التورم الناتج عن لدغات الحشرات.

٢-احمرار الجلد.

٣-ألم المنطقة المصابة.

٤-حكة.

كما تختلف شدة الأعراض الناتجة عن اللدغة باختلاف نوع الحشرة وقوة استجابة جسم الإنسان لها، وقد يصاب البعض بأعراض حساسية شديدة ورد فعل شديد اتجاه لسعات الحشرات، وتعد لسعات النحل والدبابير من أكثر اللسعات شيوعاً، وقد تتسبب عند البعض بالأعراض الشديدة، فإذا لاحظ الإنسان بداية لظهور هذه الأعراض، توجب عليه أو على من حوله الاتصال بخدمات الطوارئ؛ لأنها يمكن أن تهدد حياة الانسان، **ومن هذه الأعراض:**

القشعريرة.

المغص

الاستفراغ والغثيان

تورم في الوجه أو الشفتين أو الحلق

مشاكل في التنفس

الصدمة

الإسعافات الأولية للتورم الناتج عن لدغات الحشرات

إذا تعرض شخص ما لأعراض الحساسية الشديدة بعد اللدغ فتجب مساعدته والاتصال بخدمات الطوارئ، أما أعراض الحساسية الخفيفة كالتورم، فيمكن التعامل معه، إذ يمكن علاج التورم الناتج عن لدغات الحشرات بصورة إسعافية بأبسط الطرق منها

إذا كانت بقايا الحشرة لا تزال مغروزة داخل جلد الإنسان فيجب إزالتها عن طريق الكشط،



باستخدام أداة مسطحة الحواف ورفيعة مثل بطاقة الائتمان، ويجب تجنب إزالتها بالملقط وذلك لأن الضغط عليها قد يزيد من إفراز السموم منها.

يجب غسل المنطقة المعرضة للدغ بالصابون والماء.

يجب وضع الثلج في قطعة قماش نظيفة والقيام بالضغط على منطقة اللدغ لمدة ١٠ دقائق تقريبا،

calamine lotion لعلاج الحساسية الناتجة عن لدغات الحشرات يوضع محلول الكلامين ويعتبر الكلامين من مضادات الهيستامين التي تساعد في علاج الحساسية.

عوامل الخطر للإصابة بلسعات الحشرات هناك بعض الأمور التي تجعل الإصابة بلدغات الحشرات حالة خطيرة، إذ قد يزيد مستوى خطر لسعات الحشرات في حال التعرض للحالات الآتية والتي تشمل:

السكن في مكان قريب من تجمع وتمركز الحشرات.

العمل في بيئة تتطلب البقاء في مكان خارجي.

من المرجح أن يكون لدى الشخص رد فعل تحسسي شديد للسعات الحشرات، إذا كان لديه رد فعل تحسسي شديد في الماضي، وحتى لو كانت بسيطة،

وتكون استجابة كبار السن أكثر حدة من الأطفال، وقد تكون الحساسية المفرطة قاتلة لكبار السن أكثر من الأطفال.

علاج التورم الناتج عن لدغات الحشرات تم ذكر الأمور الأساسية سابقا لعلاج التورم الناتج عن لدغات الحشرات،

ولكن قد تتطلب بعض الحالات طرق مخصصة ودوائية مباشرة للعلاج، ومن هذه الطرق ما يأتي:

لعلاج التورم الناتج عن لدغات الحشرات Hydrocortisone استخدام كريم الكورتيزون وتهيج الجلد،

استخدام مضادات الهيستامين كالدابيفينيهيدرامين والكلوروفينيرامين لتخفيف التورم الناتج عن لدغات الحشرات وتخفيف حكة الجلد.

بعض الحالات قد تتطلب تطعيم لقاح الكزاز في غضون عدة أيام من اللدغة، إذا لم يتم تطعيم المصاب بها في السنوات العشر الماضية. استخدام الخل في حالات لدغ الدبابير فقط، وذلك لأن

الخل يحتوي على مواد حمضية تعمل على معادلة المواد القاعدية التي تفرزها لسعات الدبور، أما النحل فيفرز مواد حمضية. ولو تعرض المصاب لرد فعل شديد الحساسية، فلا بد من الحصول على إبرة الإيبينيفيرين التي تمكن المصاب من حقنها بنفسه قبل الاتصال بالرقم المخصص بالطوارئ، وعادة يستجيب الجسم للإيبينيفيرين استجابة سريعة ويمنع تفاقم أعراض الحساسية، ولكن حتى مع توقف أعراض الحساسية الشديدة سيبقى المصاب بحاجة إلى رعاية طبية طارئة، وقد يرقد المصاب في المستشفى لبضعة أيام حتى يتم الشفاء الكامل.

العلاج المنزلي للتورم الناتج عن لدغات الحشرات

بعض العلاجات المنزلية المستخدمة لعلاج لدغات الحشرات ومنها:

العسل يساعد العسل في التئام الجروح والألم والحكة، وعلاج التورم الناتج عن لدغات الحشرات، بحيث يتم وضع كمية صغيرة على المنطقة المصابة وتغطى بضمادة فضفاضة نظيفة وتترك لمدة تصل إلى ساعة.

بعض الأعشاب والزيوت **كالألوفيرا** لتبريد منطقة اللدغ،زيت **اللافندر** كمضاد للالتهاب والتورم الناتج عن لدغات الحشرات،زيت شجرة **الشاي** كمعقم للمنطقة المصابة،



لدغات الأفاعي والعقارب

يتعرض الكثير من الأشخاص للدغات الأفاعي والعقارب، وعلى الرغم من أن أغلب أنواع الأفاعي والعقارب لا تُشكل خطراً حقيقياً على حياة الإنسان، إلا أنه من الضروري التعرف على أعراض اللدغات، وكيفية التعامل معها، وكيفية تجنبها.

العقارب

ينتمي العقرب إلى طائفة العنكبيات، **ل**لعقرب جسم متطاول، وثمانية أرجل، وكماشتان في مقدمة الجسم، وذيل مكون من قطع تنتهي بالإبرة السامة التي يلدغ العقرب بها. يوجد حوالي (٢٠٠٠) نوع من العقارب في العالم، إلا أن أغلبها لا تُشكل خطراً؛ إذ إن حوالي (٢٥-٤٠) نوعاً فقط هي التي يمكنها أن تُسبب ضرراً حقيقياً، أو مميتاً للإنسان، وعلى الرغم من ذلك لدغة العقرب مؤلمة، ويمكن أن تكون قاتلة خاصةً إذا كان الملدوغ طفلاً.

أعراض لدغة العقرب

يُشعر الشخص الذي يتعرض للدغ العقرب بألم، ووخز، وخدر مكان الإصابة، وتكون الأعراض غالباً خفيفة، إلا أن بعض الأشخاص قد يُعانون من أعراض شديدة تشمل:

-صعوبة البلع

-عدم وضوح الرؤية

- تشنج

-زيادة إفراز اللعاب

-صعوبة في التنفس

-حركة العين غير الطبيعية

-خدر يمتد بعيداً عن مكان اللدغ



طريقة التعامل مع لدغات العقرب

يجب على المُصاب والمُحيطين به اتخاذ الإجراءات الآتية عند التعرض لدغة العقرب:

تنظيف منطقة اللدغ بالماء، والصابون وذلك للتخلص من بقايا السُّم وتقليل خطر الإصابة بالتهاب.

تهدئة المُصاب والحد من حركته.

إبقاء مكان اللدغ على مستوى القلب، أو أقل لإبطاء انتشار السُّم.

تطبيق كمادات باردة على منطقة الإصابة لمدة (١٠-١٥) دقيقة، وإزالتها لمدة عشر دقائق، وتكرار ذلك خلال أول ساعتين من حدوث اللدغ، وذلك لتقليل الألم والورم، ومنع انتشار السُّم بسرعة في الجسم، وإذا كان المُصاب يُعاني من مشاكل في الدَّورة الدموية يجب أن لا تزيد فترة وضع الكمادات الباردة عن (٥) دقائق كل مرة.

تناول مُسكنات الألم، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل: الإيبوبروفين، والإسبيرين، والالتزام بالتعليمات المرفقة،

وإذا كان الألم شديداً يجب استشارة الطبيب.

طلب المساعدة الطبية العاجلة إذا فقد المُصاب وعيه، أو تعرض لتشنُّجات شديدة، وإجراء خطوات الإنعاش القلبي عند الاشتباه بتوقف القلب عن النبض.



مراجعة الطبيب بعد إجراء الإسعافات الأولية للمصاب حتى لو شعر بالتحسُّن، وقد ينصح الطبيب بأخذ مطعوم الكزاز، أو مرخيات العضلات، والمضادات الحيوية لتجنُّب حدوث مضاعفات.

يجب استدعاء العناية الطبية العاجلة في الحالات الآتية:

إذا كان المصاب طفلاً،
أو أحد الكبار في العمر،
.أو لديه مشاكل في القلب، أو الرئة
إذا ظهرت على المصاب الأعراض الآتية:
التقيؤ
التعرُّق
سيلان اللعاب، أو خروج رغوة من الفم
التبوُّل، أو التبرُّز اللاإرادي
تشنج العضلات، وعدم القدرة على التحكم بعضلات الرأس، والرّقبة، أو حركات العين
صعوبة المشي
عدم انتظام ضربات القلب
.صعوبة في البلع، والكلام، والتنفُّس، أو الرؤية
التورُّم الشديد الناتج من رد فعل تحسُّسي

الوقاية من لدغ العقارب

للوقاية من لدغ العقارب يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية:
تجنُّب الاحتفاظ بأكوام الخشب، والصُّخور في المنطقة المُحيطة بالممنزل،
تقليم الأشجار المُحيطة بالمنزل لضمان عدم وصول العقارب منها إلى الداخل،
وقص العُشب بانتظام.
إغلاق الشقوق،
واستخدام المواد العازلة حول الأبواب والنوافذ لمنع دخول العقارب للمنزل.
فحص وتفقد الأحذية والملابس التي لم تُستخدم لفترة طويلة قبل ارتدائها، وكذلك قفازات
ارتداء ملابس تُغطّي الساقين والذراعين عند المشي أو التخييم،
وتفقد أكياس النّوم قبل استخدامها.



الأفاعي

إن أغلب الأفاعي غير سامة، وعلى الرغم من ذلك فإن التعرض للدغ من أي أفعى سيكون سيئاً. من الصعب التمييز بين الأفاعي السامة والأفاعي غير السامة لذلك يجب التعامل مع لدغات جميع الأفاعي وكأنها سامة. ومن أشهر الأفاعي السامة يمكن ذكر الأفعى نحاسية الرأس، والأفاعي المرجانية، وأفعى الخف المائية، والأفاعي المجلجلة.



أعراض لدغ الأفعى السامة

يمكن تمييز لدغة الأفعى عن غيرها بوجود ثقبين أو جرحين في منطقة اللدغ، وتختلف أعراض لدغ الأفعى السامة باختلاف نوع الأفعى، بشكل عام إن

أعراض لدغة الأفعى هي كالآتي:

١-الشعور بالضعف، والدوار.
٢-فقدان الوعي.
٣-التشنجات
٤ غثيان، وقيء، إسهال.
٥-زيادة سرعة النبض.
٦-اضطراب التنسيق العضلي.

٧-تورّم واحمرار في منطقة اللدغ.
٨-خدر في الوجه والأطراف.
٩-الشعور بالألم في منطقة اللدغ.
١٠-اضطراب الرؤية.
١١-صعوبة التنفس
١٢-التعرق، وسيلان اللعاب

الإسعافات الأولية لدغة الأفعى

من الأمور الواجب مراعاتها عند التعرض لدغ الأفعى الآتي:
طلب المساعدة الطبية بشكل عاجل.
الهدوء.
والحد من الحركة قدر الإمكان؛ لأن الحركة تُسرّع من انتقال السم في الجسم.
التخلص من المجوهرات أو الألبسة المحيطة بمنطقة اللدغ لأنها ستتورّم.
التقاط صورة للأفعى إن أمكن للتعرّف على نوعها، وتحديد العلاج المناسب.
تنظيف الجرح بلطف، وتغطيته بقطعة قماش نظيفة.



عند الوصول إلى المركز الطبي يمكن تحديد العلاج اعتماداً على الأعراض التي تظهر على المصاب، وقد يبقى المُصاب تحت المراقبة الطبية لمدة ٢٤ ساعة؛ حيث إن بعض الحالات قد تستغرق وقتاً طويلاً لتطور الأعراض لديها.

قد يشمل العلاج الطبي إعطاء المُصاب مضاداً لسُمّ الأفعى، ومضاداً حيوياً لمنع التهاب الجرح، ومطعوم الكزاز، وفي حالة اللدغات الشديدة قد يلجأ الطبيب للجراحة.

إن الأمور الواجب الامتناع عنها عند التعرض لدغة أفعى، لأنها قد تزيد الوضع سوءاً، فهي

امتصاص السُمّ عن طريق الفم،

غسل منطقة اللدغ، لأنَّ ذلك سيفوت فرصة فحص بقايا السُم والتعرف على نوع الأفعى، و تحديد العلاج الأفضل.

رفع منطقة اللدغ فوق مستوى القلب

إعطاء المصاب مسكنات للألم، أو أية أدوية إلا تحت الإشراف الطبي

تناول أي نوع من الطعام، أو الشراب

الوقاية من لدغ الأفاعي

للوقاية من لدغ الأفعى ينصح بما يلي:

تجنب الجلوس، أو إدخال الأيدي في الأماكن التي قد تشكل مخبأ ملائماً للأفاعي مثل، الأجمات، أو بالقرب من الأشجار، والأعشاب الطويلة، أو الصخور.

الانتباه والنظر للأسفل أثناء المشي في الأماكن التي قد تتواجد فيها أفاعي.

عدم محاولة الإمساك بأفعى حتى لو كانت ميتة، لأن بعض الأفاعي لديها القدرة على اللدغ بعد موتها بدقيقة أو نحوها.

ارتداء أحذية المشي طويلة العنق.

افتعال الضجة أثناء المشي في أماكن تواجد الأفاعي، لإعطائها الفرصة للهرب.

